Manual de Gestión de Psicología en los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

Código MG.GM.DDSS.ARSDT-PSI-231118

V2

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

2025

ELABORADO POR:	Dra. Cinthia Chacón Barquero, psicóloga, Coordinación Nacional de Psicología Dra. Sara Cubillo Escalante, psicóloga clínica, Coordinación Nacional de Psicología Dra. Mariela Fletes Brenes, psicóloga, Coordinación Nacional de Psicología. Dr. Alfonso Villalobos Pérez, psicólogo, Coordinación Nacional de Psicología.	
EQUIPO CONSULTIVO	Dra. Grace Asenjo Ramírez, psicóloga clínica, Hospital Dr. Maximiliano Peralta. Dra. Rita Cerdas Fonseca, psicóloga clínica, Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla. Dra. Kendra Clarke Hines, psicóloga, Área de Salud Siquirres. Dra. Maureen Granados Jiménez, psicóloga clínica, Hospital Nacional de Niños. Dra. María del Rocío Jiménez Mora, psicóloga clínica, Hospital Nacional de Salud Mental. Dra. Kathia Mora Fonseca, psicóloga clínica, Hospital Dr. Maximiliano Peralta Dra. Milagro Picado Arias, psicóloga clínica, Hospital San Rafael de Alajuela Dra. Tatiana Ramírez Gómez, psicóloga, Dirección de Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central. Dra. Ninfa Salas González, psicóloga clínica, Dirección de Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte. Dra. Karla Villalobos Carrillo, psicóloga, Área de Salud Cañas.	
VALIDADO POR:	Dra. Andrea Brenes Chaves, psicóloga	Área de Salud Paraíso Cervantes
	Dra. Grettel Solano Quesada, psicóloga	Área Salud Cañas
	Dr. Javier Rojas Elizondo, psicólogo clínico	Centro Nacional de Cuidados Paliativos y Dolor Crónico
	Dra. Julia Lizeth Barquero Madrigal, psicóloga	Área de Salud Sarchí
	Dra. Karla Gabriela Villalobos Carrillo, psicóloga clínica	Área de Salud Cañas (CAIS) / Enlace Regional Psicología Región Chorotega
	Dr. Luis Fernando Picado Gutiérrez, psicólogo	Área de Salud Curridabat
	Dra. Marcela Peralta Carranza, psicóloga clínica	Area de Salud Desamparados 3
	Dra. Ninfa Salas González, psicóloga clínica	Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte
	Dra. Rita Cerdas Fonseca, psicóloga clínica	Hospital Escalante Pradilla
	Dra. Vivian Giselle Morera Herrera, psicóloga	Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón
	Dra. Yancy Milena Solano Chacón, psicóloga clínica	Hospital Nacional de las Mujeres

REVISADO Y APROBADO POR:	Dra. Marta Vindas González, Coordinadora Nacional de Psicología
AVALADO POR:	Dr. Alejandro Sánchez Cabo, Gerente Médico Mediante Oficio # (Ver anexo 1)
Fecha de revisión y aprobación	2025
Próxima revisión:	2032
Observaciones	Se procede aclarar los roles metodológicos donde el equipo colaborador participo con la entrega de insumos como análisis técnicos sobre los diversos contenidos del manual, insumos relacionados con datos y revisión de la versión borrador del documento. El equipo validador participo en el llenado del formulario electrónico para la validación. Es importante destacar que este documento, al tratarse de una segunda versión, incorpora múltiples modificaciones entre ellas se incluyen: • Se procede a la actualización de normativas, conceptos y definiciones regulatorias para la disciplina. • Se especifican las modalidades de atención basadas en la evidencia y respaldadas por referencias científicas. • Se actualizan los escenarios autorizados para la intervención psicológica por tipo de establecimiento y nivel de atención. • Otro aspecto incorporado en el documento son las comisiones que se encuentran reguladas mediante criterios claros de inclusión y exclusión. • Se actualizan los criterios de planificación los cuales deben de responder a una distribución porcentual de las actividades, según el tipo de establecimiento (I, II, III nivel). • Se especifica la ruta a seguir para generar los criterios de referencia y contrarreferencia en cada nivel de atención. • Se incorpora la telepsicología como una modalidad más de atención. • Se actualiza la regulación del uso de instrumentos psicológicos, incluyendo su adquisición, trazabilidad y registro obligatorio en el EDUS. La reproducción gratuita de este material con fines educativos y sin fines de lucro es permitida, siempre y cuando se respete la propiedad intelectual del documento. No se permitirá la reproducción comercial del producto sin la autorización de la CCSS y la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Se utilizan las siguientes siglas para indicar los lugares de trabajo: • ARSDT: Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento

Consultas al: correo cnsp_ars@ccss.sa.cr

Declaración de Intereses:

Los autores de este documento declaran que no ha existido ningún tipo de conflicto de interés en su realización. Que no poseen relación directa con fines comerciales con la industria sanitaria en dicho tema, no han recibido dinero procedente de la investigación o promoción de dicho tema. Además, declaran no haber recibido ninguna directriz de parte del solicitante o pagador (CCSS) para variar técnicamente el contenido de este documento. Cada colaborador llenó su respectivo formulario de declaración de intereses, el cual fue analizado por la Coordinación Nacional de Psicología y tomó las debidas acciones; los formularios serán custodiados por 5 años.

Índice

Presentación 7
Introducción 8
Metodología 10
Definiciones, abreviaturas y símbolos 12
Referencias normativas 24
Leyes 24
Reglamentos y Políticas 24
Documentos de regulación técnica institucionales 25
Abreviaturas: 27
Alcance y campo de aplicación 28
Objetivo General 29
Objetivos específicos 29
Responsable del cumplimiento 29
Responsable de verificar el cumplimiento 30
Contenido 31
Ubicación Contextual 31
Gestión de la actividad de psicología en la CCSS 32
Gestión procesual de las actividades de psicología en la CCSS 33
Definición de la actividad de psicología en la Institución 34
Descripción del Componente de Psicología en la Institución 35
Áreas de Salud (tipo I; II y III), 36
Hospitales periféricos y regionales 36
Hospitales Nacionales, Hospitales Especializados y Centros Especializados 37
Conformación de las prestaciones de servicios psicológicos a las personas usuarias 38
Oferta de servicios psicológicos en los tres niveles de atención de la Caja 39
Descripción de actividades 43
Áreas de Salud tipo I, II y III 44
Hospitales regionales y periféricos 48
Hospitales nacionales, hospitales y centros especializados 51
Oferta de Servicios para las personas usuarias 55
Escenarios y Modalidades de atención: 56
El plan de atención y seguimiento en psicología: 57
Procedimientos psicológicos: 57
Procedimientos para el Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS). 58
Registro de atenciones en EDUS: 58
Sistema de Referencias y Contrarreferencias en la Red de Prestación de Servicios de Salud de Psicología para los Tres Niveles de Atención. 61

Mecanismos de referencia en los servicios de Psicología de la CCSS 65
Áreas de Salud tipo I, II y III 65
Criterios para referir una persona usuaria a los hospitales periféricos o regionales 69
Hospitales periféricos y regionales 70
Estrategia de filtrado, valoración y atención psicoterapéutica 70
Criterios para derivación al Tercer Nivel 73
Tercer Nivel de Atención 74
Estrategias de atención de mayor especialización 74
Mecanismos de Contrarreferencia 78
A. Hospitales nacionales y hospitales-centros especializados hacia hospitales periféricos y regionales 78
B. Contrarreferencias desde los Hospitales Periféricos y Regionales a las Áreas de Salud tipo I, II y III 79
Criterios de alta en cada nivel 79
A. Alta en las Áreas de Salud tipo I, II y III 80
Seguimiento psicológico de las personas usuarias a través de la Red de Prestación de Servicios de salud. 81
Organización Funcional 87
Relación con el mapa de Procesos Institucional 88
Descripción de la organización funcional 89
Funcionamiento Interniveles: 90
Funciones por nivel de atención 91
Equipamiento e infraestructura 97
Equipamiento 97
Infraestructura 98
Evaluación de resultados 99
Declaración de Intereses 100
Contacto para consultas 100
Anexo 1 101
Referencias 102

Presentación

El presente Manual de Gestión constituye un Documento de Normalización Técnica (DNT) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), correspondiente a la segunda edición del Manual de Gestión de Psicología. Su contenido responde a la necesidad de actualizar la normativa que regula los procesos en el ámbito local de la disciplina, en concordancia con el proceso misional PM-02: Prestación de Servicios de Salud, eje articulador del Mapa de Procesos Institucionales de la CCSS.

A partir de ese imperativo, es que la gestión de la actividad de psicología en el ámbito local debe estar organizada de acuerdo con el marco legal y técnico, que engloba el quehacer de la CCSS y de esta profesión. Todo esto con el fin de mantener actividades sustantivas, complementarias y de apoyo, que sumen en la atención a las personas usuarias.

El presente documento, integra la operativización de esas acciones generales, que deben seguir los profesionales de psicología de la CCSS, en su quehacer diario, en la rendición de cuentas sobre sus actividades laborales, así como en la integridad de su actuación frente a la demanda en salud psicológica de las personas usuarias, en los diferentes ámbitos aprobados y ejecutados desde la diversidad del conocimiento técnico de estos profesionales, para la eficiente gestión de la psicología en los tres niveles de atención.

Es importante señalar que este documento fue elaborado mediante el proceso metodológico participativo, técnico y consultivo, que incluyó la revisión normativa vigente, análisis de procesos misionales, consulta a profesionales de los tres niveles de atención, y validación institucional. Este enfoque permitió asegurar la pertinencia, aplicabilidad y alineación del documento con los objetivos estratégicos de la CCSS. En complemento con lo anterior, el presente documento se organiza sobre las características epidemiológicas de las poblaciones que se atienden, se basa en un modelo de atención en salud pública centrado en la persona.

La actual regulación favorece que los procesos de atención psicológica se orienten sobre principios de calidad y calidez, coherente con la obligaciones legales, técnicas y sociales que nos demanda la sociedad como son el fortalecimiento de los factores de protección en salud y la atención de la enfermedad.

Introducción

La presente normativa corresponde al Manual de Gestión de Psicología en los Establecimientos de Salud de la CCSS, el cual forma parte de los Documentos de Normalización Técnica (DNT) para la regulación de la prestación de los servicios. Este manual responde a la necesidad de contar con una herramienta operativa que regule, ordene y oriente la prestación de servicios psicológicos en los tres niveles de atención, en concordancia con el Modelo de Atención en Salud vigente desde 1993.

Su elaboración se justifica en la identificación de vacíos operativos y regulatorios, especialmente en lo relativo a la articulación entre niveles de atención y la delimitación de funciones profesionales en los distintos escenarios clínicos. En este sentido el manual busca consolidar criterios técnicos y administrativos que permitan una atención psicológica eficiente y alineada a los principios de legalidad, cientificidad y pertinencia institucional.

Este documento se vincula explícitamente con el Proceso Sustantivo PM-02 y otros Documentos de Normalización Técnica vigentes, como la Oferta de Servicios de Psicología, la organización funcional, las instrucciones de trabajo y protocolos de atención clínica actualizados. Su propósito es servir como una guía para la gestión integral de los servicios de psicología en los diferentes componentes de la salud: promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y curación en consulta externa, hospitalización, servicios de emergencia y otros escenarios fuera de los establecimientos de salud.

Desde la publicación de la primera Oferta de Servicios de Psicología en el año 2012 por parte de la Coordinación Nacional de Psicología, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento de la Dirección de Desarrollo Servicios de Salud adscrita a la Gerencia Médica, se ha avanzado en la regulación institucional de la disciplina, defendiendo estrategias fundamentales para responder a las demandas poblacionales en salud y enfermedad psicológica. Este manual representa una actualización normativa que consolida dichos avances y los articula con las leyes nacionales en la materia como lo son la Ley General de Salud, Ley Nacional de Salud Mental, Ley General de Administración Pública y la Ley de Control Interno.

Este documento de regulación técnico deja sin efecto y sustituye las siguientes regulaciones:

- Manual de Gestión de Psicología en los establecimientos de salud de los tres Niveles de Atención, código MTG.GM.DDSS.ARSDT.PSI-23112018 y avalado en nota GM-DESP-15905.

- Oferta de servicios de psicología 2018-2023, código MTG-GM-DDSS-ARSDT-PSI-290818, avalado en nota GM-MDD-3970-2018.

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la elaboración del presente manual, la cual integra revisión documental, análisis técnico y validación institucional.

Metodología

El Manual de Gestión de Psicología para los tres niveles de atención fue diseñado con base en el criterio técnico de profesionales expertos en psicología que integraron el equipo consultivo, seleccionados por su experiencia en los distintos niveles de atención. La inclusión del manual en el Plan Presupuesto del Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento 2024-2025 permitió formalizar el proceso de construcción.

Para garantizar la calidad técnica y metodológica del documento, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de publicaciones científicas recientes en el ámbito de la psicología clínica y la salud pública, tanto a nivel nacional como internacional. Esta búsqueda permitió identificar buenas prácticas, modelos de atención efectivos y lineamientos técnicos actualizados que fundamentaron el contenido del manual. Asimismo, se analizaron los documentos normativos vigentes de la CCSS, incluyendo el Manual de Gestión para la Construcción de Documentos Normativos, Código M.GM.DDSS.110621, lo que aseguró la alineación del nuevo manual con el marco regulatorio actual.

La redacción técnica del documento se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual Metodológico correspondiente, lo que permitió asegurar trazabilidad metodológica y transparencia en cada etapa del proceso.

Se describen los diferentes procedimientos llevados a cabo para la creación de este documento regulatorio:

- Para la validación del Manual, se convocó a profesionales de psicología de los tres niveles de atención, a través de la Gerencia Médica y de la Dirección de Red de Servicios de Salud, canalizando la comunicación a través de las Direcciones Generales y las Direcciones Médicas, dada la ausencia de una estructura formal en los servicios de psicología.

- Convocatoria al equipo consultivo de acuerdo con notas: GM-2111-2024 (colaboradores del III Nivel), DRSS-GAL-0126-2024 (profesionales del I y II Nivel), DDSS-ARSDT-0409-2024 (profesional que coordina el EIS en la Gerencia Administrativa). Las diversas reuniones permitieron realizar un análisis de las posibilidades de cambio y fortalecimiento del Manual de Gestión del 2018 y la Oferta de Servicios de ese mismo año. Se realizaron propuestas base que fueron el insumo para las versiones de validación.

- La validación técnica se solicitó mediante las notas DDSS-ARSDT-0470-2025 (dirigida al III Nivel) y DDSS-ARSDT-0471-2025 (remitida a las

Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud, DRIPSS), utilizando el formato RAND-UCLA con estructura Delphi modificada, avalado por la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.

La encuesta de validación incluyó 27 ítems, cada uno valorado en una escala del 1 al 9, donde 1 representa desacuerdo total y 9 acuerdo total. El instrumento fue habilitado desde el 28 de abril hasta el 26 de mayo de 2025. Participaron 65 profesionales en psicología, sin embargo, conforme al procedimiento establecido en el Manual Metodológico para la construcción de un Manual de Gestión (CCSS, 2021, págs. 26–27), solo se consideraron válidas las respuestas que incluyeron la firma de la Declaración de Intereses. Esta Coordinación Nacional de Psicología recibió 11 declaraciones de intereses debidamente firmadas, por lo que únicamente estos profesionales aparecen en la lista oficial de validadores.

Los resultados cuantitativos de la validación reflejaron un promedio general de 8 sobre 9, lo que equivale a un nivel de acuerdo del 88.9%. Las validaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución de validaciones:

- 6 de Áreas de Salud
- 2 de Hospitales Especializados
- 2 de Hospitales Regionales
- 1 de DRIPSS

Una vez recibidas las diferentes manifestaciones de los validadores, se procedió a aplicar las modificaciones que, según la legislación y normas nacionales, eran viables de incluir. Todos los aportes fueron analizados rigurosamente y considerados en la versión final del documento, asegurando así la trazabilidad metodológica, la transparencia en la construcción y la coherencia técnica del manual.

Definiciones, abreviaturas y símbolos

Cuadro 1.
Conceptos y definiciones

Concepto	Definición
Adscripción	A toda persona asegurada o no, de acuerdo con el lugar de residencia habitual y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Caja para tal efecto, se le asignará un único establecimiento de salud del primer nivel de atención, el cual conservará en tanto resida dentro de su área de atracción. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2014).** *Manual de adscripción y beneficio familiar*. CCSS https: www.ccss.sa.cr/normativa
Alta	La *alta médica* se refiere al acto clínico mediante el cual se determina que una persona usuaria ha alcanzado un estado de salud que permite su egreso del centro hospitalario, ya sea por recuperación, traslado, seguimiento ambulatorio o decisión médica fundamentada. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2017).** *Manual de Procedimientos: Alta Programada*. Repositorio BINASSS. https://repositorio.binasss.sa.cr/bitstreams/0f031ad2-6aea-49db-95c3-1aa520517555
Área de Atracción	"Área geográfica definida institucionalmente que abarca un centro de salud de la CCSS, en el cual los asegurados y profesionales que residan o ubiquen sus consultorios, respectivamente, dentro de dichos límites, deben inscribirse para recibir atención." **Caja Costarricense de Seguro Social. (2015).** *Reglamento del Sistema Mixto de Atención en Salud*. Aprobado por la Junta Directiva en sesión N.º 8755 del 11 de diciembre de 2014. Publicado en La Gaceta N.º 23 del 3 de febrero de 2015.
Área de Salud	Unidad territorial y operativa que articula los servicios de atención primaria y especializada, conformada por uno o varios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), clínicas, y hospitales periféricos, según la organización regional de la institución. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2015).** *Reglamento del Sistema Mixto de Atención en Salud*. Aprobado por la Junta Directiva en sesión N.º 8755 del 11 de diciembre de 2014.
Atención en Emergencias	La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) define "atención en emergencias" como el conjunto de acciones clínicas, administrativas y

	logísticas destinadas a brindar atención inmediata, segura y continua a personas con condiciones agudas que comprometen su vida, función o salud, en cualquier nivel de atención institucional. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2017).** *Informe técnico para el fortalecimiento de la atención de emergencias en la CCSS*. Gerencia Médica, Comisión CASEM.
Atención Integral	La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) define "atención integral" como un enfoque de salud centrado en la persona, que articula acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, considerando los aspectos físicos, emocionales, sociales y culturales de cada individuo. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2003).** *Módulo 3: La Atención Integral*. Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), Curso Especial de Posgrado en Gestión Local de Salud. https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/La%20gesti%C3%B3n%20en%20la%20atenci%C3%B3n%20integral%20en%20salud
Atención psicológica	Se refiere a la aplicación de las actividades técnicas de Psicología, contenidas en los documentos de regulación avalados para esta disciplina en el ámbito de la CCSS. Esta actividad se orienta a la promoción de salud psicológica, prevención primaria, el diagnóstico y evaluación psicológica, la intervención y tratamiento psicoterapéutico (en las modalidades avaladas en la CCSS para la disciplina) y la rehabilitación. Incluye a la aplicación e interpretación de procedimientos (instrumentos de medición psicológicos), así como el desarrollo de sesiones clínico técnicas (uni o interdisciplinarias) y la participación en comisiones o equipos avalados oficialmente por la Gerencia Médica. Estas actividades se desempeñan de acuerdo con el Modelo de Atención en Salud vigente en el país, de acuerdo con la complejidad del establecimiento de salud donde se realiza la atención psicológica. **Coordinación Nacional de Psicología. (2025)**
Bienestar psicológico	Experiencia subjetiva que integra el sentir positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, en estrecha relación con su entorno físico, psíquico y social. Se caracteriza por su naturaleza vivencial, influida por la personalidad y las circunstancias ambientales, y se considera un constructo dinámico que puede ser promovido desde prácticas alternativas en salud **López, M., Gillet, S., & Zabaletta, V. (2022).** *Aportes al constructo bienestar psicológico desde las prácticas alternativas en salud*. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 14(Extra 1), 130–131. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9066840

Capacidad instalada	"En general se refiere al volumen de producción que se puede obtener con los recursos disponibles en un determinado momento, incluye recursos como; dinero, equipo, personal, instalaciones, etc" **Caja Costarricense de Seguro Social. (2022a).** Informe de clasificación de áreas de salud. Gerencia Médica. https://GM-5210-2022-GF-1511-2022-ANEXO1.pdf
Capacidad resolutiva	Es la determinación del tipo de diagnóstico que es posible atender en cada establecimiento de salud, las demandas locales, desde una visión integral, según su nivel de complejidad, con el fin de satisfacer las necesidades y demandas de la población y a la vez un uso óptimo de los recursos disponibles (Clèries Costa, Sarrado Soldevilla y López Vicente, 2007).
Comisiones	Una comisión de trabajo es un conjunto de personas encargadas por una autoridad superior, elegidas o designadas para ejercer unas determinadas competencias o atender algún asunto específico, en representación de la organización. Las mismas pueden ser permanentes o temporales, de acuerdo con la siguiente descripción: Comisiones permanentes: son las que se establecen por reglamento, con duración ilimitada y con objetivos específicos, según lo definido por la autoridad superior que las designa. Comisiones temporales: se refieren a las que son integradas para atender asuntos específicos determinados por la autoridad superior, una vez alcanzado el objetivo asignado, la comisión nombrada pierde su razón de ser y deja de existir. (CCSS; 2012b) Las comisiones deben estar formalizadas por las Gerencias o Presidencia Ejecutiva y están sujetas a procesos de gestión y control de riesgos, por lo que deben organizarse (sus miembros), de acuerdo con una planificación preestablecida, efectuar las acciones para las que fueron aprobadas y rendir informes en los periodos establecidos por los DNT que las rigen.
Comorbilidad	"Comorbilidad, también conocida como *morbilidad asociada*, es un término médico que se utiliza para referirse a la presencia de dos o más enfermedades o trastornos al mismo tiempo en una persona. Esta condición implica que puede existir una interacción entre las enfermedades, lo cual puede empeorar la evolución de ambas." (Organización Mundial de la Salud, 2021).
Complejidad de los establecimientos de salud	Complejidad en un establecimiento de salud se refiere al nivel de capacidad técnica, organizativa y resolutiva que posee una unidad médica para atender

	las necesidades de salud de la población adscrita, considerando la oferta de servicios, el recurso humano disponible, el equipamiento, y los factores epidemiológicos y sociodemográficos del entorno. Esta clasificación permite a la CCSS planificar y asignar recursos de manera equitativa y eficiente, fortaleciendo la red institucional de atención en concordancia con el modelo de atención vigente. **Caja Costarricense de Seguro Social (2016).**
Consulta Externa o ambulatoria	Consulta externa: se refiere a la atención de usuarios de los servicios de salud (en este caso Psicología), por parte de especialistas en la rama específica. Incluye una serie de requisitos generales en cada una de las modalidades de consulta externa, a saber (Madrigal, 2012): 1. Aprobación de agenda por parte de la jefatura de la consulta externa. 2. Existencia de un horario de atención. 3. Identificación del escenario de atención. 4. Otorgamiento de cita previa o cupo por demanda. 5. Identificación de la consulta. 6. Registro de la atención en el expediente de salud, y 7. Reporte estadístico **Caja Costarricense de Seguro Social (2014).**
Contrarreferencia	Es la emitida por el profesional en salud con el propósito de que el establecimiento o área de salud que refirió a la persona, conozca de lo actuado por éste y pueda incorporarlo en el expediente de salud, que de ella se tiene. Es un instrumento de comunicación entre el personal de salud para brindarle mayor integralidad a la atención (Madrigal, 2012). **Caja Costarricense de Seguro Social (2014).**
Demanda	El número y tipo de prestaciones que social y técnicamente requiere una población determinada en un período establecido. Implica traducir las necesidades en salud de una población en necesidades de prestaciones en salud. Puede subdividirse en la demanda expresada (equiparado con utilización y adicionado a la lista de espera) y demanda potencial, la cual incluye la demanda no sentida por el sistema de salud porque el usuario no ha solicitado los servicios. También puede ser subdividida en la demanda racional (exigencia que corresponde a necesidad) y demanda irracional (exigencia que no corresponde a necesidad objetiva) y, por último, en demanda satisfecha y demanda insatisfecha que se refieren a la capacidad de los servicios de salud (oferta) de cubrir toda la demanda (Carballo-Quesada, 2022; Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2011).
Determinantes de la salud	Los determinantes de la salud incluyen: • el entorno social y económico, • el entorno físico y • las características y conductas individuales de la persona.

	El contexto de la vida de las personas determina su salud, por lo que culpar a las personas por tener mala salud o atribuirles la buena salud es inadecuado. Es poco probable que las personas puedan controlar directamente muchos de los determinantes de la salud (WHO, 2025a).
Efectividad	La capacidad de una intervención, programa o servicio para lograr los resultados deseados en condiciones reales; esto implica: • Impacto positivo en la salud mental y bienestar de la población usuaria. • Aplicación de intervenciones basadas en evidencia científica, adaptadas al entorno institucional y comunitario. • Evaluación continua de resultados clínicos, funcionales y sociales. • Alineación con los principios de equidad, accesibilidad y pertinencia cultural. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2023)**. *CCSS 2041: Una Mirada al Futuro*. Dirección de Planificación Institucional. https://aissfa.ccss.sa.cr/flip/documents/mirada/pdf/full.pdf
Eficiencia	La eficiencia en salud pública se refiere a la capacidad institucional para maximizar los resultados en salud utilizando los recursos disponibles de manera óptima, garantizando servicios oportunos, sostenibles, de calidad y centrados en las personas. Esto implica: • Uso racional de recursos humanos, financieros y tecnológicos. • Reducción de desperdicios y duplicidades. • Mejora continua en procesos administrativos y clínicos. • Evaluación constante de indicadores de desempeño. **Caja Costarricense de Seguro Social. (2023).** *Plan Estratégico Institucional 2023-2033*. https://aissfa.ccss.sa.cr/arc/pei/pei_2023_2033.pd
Equipo de Apoyo	Equipo integrado por personal de los diferentes Servicios de Apoyo ubicados en la Sede del Área, con el propósito de apoyar a los Sectores adscritos para atender las necesidades y los problemas de salud específicos, según sus características particulares (CCSS, 2002). Caja Costarricense de Seguro Social (2002). Manual de organización de las áreas de salud. Aprobado por la Junta Directiva en Sesión No. 7571 del 16 de agosto de 2001.
Establecimiento de salud	Los establecimientos de salud prestan servicios sanitarios a los pacientes y su tamaño varia desde pequeños dispensarios hasta muy grandes hospitales. (Organización Panamericana de la Salud [OMS], 2021)

Evaluación psicológica	La evaluación psicológica es un proceso clínico y científico, sistemático y ético, que integra información proveniente de entrevistas, observación y pruebas psicométricas validadas, con el fin de describir y comprender el funcionamiento psicológico de una persona, apoyar el diagnóstico y orientar decisiones de intervención en salud. Se fundamenta en principios de validez, fiabilidad, pertinencia cultural y uso responsable de los datos.
Factor de riesgo	Cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a una enfermedad (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2025).
Gestión por procesos	Es una estrategia organizacional orientada a alcanzar la eficiencia dentro de los procesos productivos que la organización o empresa ejecuta. (Byron Cisneros, et al 2017)
Hospital	Los hospitales complementan y amplifican la eficacia de muchas otras partes del sistema de salud, proporcionando una disponibilidad continua de servicios para afecciones agudas y complejas. Concentran los escasos recursos en redes de derivación bien planificadas para responder de manera eficiente a las necesidades de salud de la población. Son un elemento esencial de la cobertura sanitaria universal y serán fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (WHO, 2024b)
Interconsulta	“Es el acto mediante el cual un profesional en medicina solicita la opinión o criterio a otro profesional experto en su campo, acerca de alguna condición física, emocional o social específica, dicha respuesta contendrá el juicio y las recomendaciones sobre la asistencia y el tratamiento a seguir respecto a la condición consultada, a fin de emitir un diagnóstico integral al paciente.” (Caja Costarricense de Seguro Social, 2024b, p 5)
Interculturalidad	El concepto involucra las interrelaciones equitativas, respetuosas de las diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, etarias, lingüísticas, de género y generacionales, establecidas en un espacio determinado entre las diferentes culturas (pueblos, etnias) para construir una sociedad justa (Organización Panamericana de la Salud, 2025).
Interdisciplinariedad	La interdisciplinariedad en salud pública es un proceso colaborativo, estructurado e integrador en el que profesionales de distintas disciplinas combinan sus marcos conceptuales, métodos de investigación, competencias clínicas y enfoques de intervención para comprender y abordar problemas de salud de manera conjunta.

	Implica la construcción de un modelo compartido de análisis y acción, donde el intercambio de información, la co-creación de diagnósticos y la toma de decisiones se realizan de forma coordinada, con el fin de generar soluciones más eficaces, equitativas, culturalmente pertinentes y sostenibles en el nivel poblacional.
Modelo de Atención en Salud de la CCSS	Se basa en los principios de universalidad, solidaridad y equidad de la prestación de servicios de salud. Su estructura conceptual y metodológica se orienta sobre un enfoque bio-psico-social, del proceso de salud-enfermedad, sustentado en una atención integral continua (dentro de un modelo de referencia y contarreferencia en la Red de Servicios de Salud), de la salud de las personas y su ambiente. Sus ejes integrales se organizan en el flujo: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Las prestaciones de salud, se estructuran a lo largo de una gradualidad creciente en complejidad, articulada en tres niveles de atención: I Nivel (áreas de salud), II nivel (hospitales periféricos y regionales) y III Nivel (hospitales nacionales y hospitales-centros especializados). (basado en la definición de: CCSS, 1998).
Morbilidad	Número de personas que enferman en una población y periodo determinados (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2025).
Niveles de Atención	La CCSS está conformada por un conjunto de establecimientos de salud, organizados en 3 Niveles de Complejidad con distintos grados de capacidad resolutiva, interrelacionados entre sí, articulados de forma vertical u horizontal. Esta complementariedad asegura la provisión y continuidad de un conjunto de servicios en salud destinados a satisfacer necesidades y demandas de la población e incrementar la capacidad operativa de la Institución. Desde el punto de vista de la respuesta de los servicios de salud a las necesidades del usuario, los Niveles de Complejidad corresponden a combinaciones funcionales de servicios, de los cuales los de menor complejidad resolutiva, denominados de Primer Nivel, comprenden las acciones más elementales o básicas del sistema. Los otros niveles: Segundo Nivel y Tercer Nivel, corresponden a agrupaciones de servicios de diferente grado de especialización y complejidad mayor resolutiva ascendente, que actúan en general sobre la base de referencia del Primer Nivel. En otras palabras, lo que distingue a un nivel de otro es su capacidad tecnológica y la dotación de recurso humano, lo que redunda, en la resolución de problemas (Caja Costarricense de Seguro Social, 2023).
Persona usuaria	Según el reglamento del expediente de salud podemos definir usuario en este caso como: “Artículo 8. Paciente. Persona que recibe atención en los servicios de salud de la Caja, sean éstos, de carácter preventivo, curativo o de rehabilitación.” (Caja Costarricense de Salud, 2018)

Perspectiva de Género	La perspectiva de género es un **enfoque analítico y práctico** que reconoce que: • **El género** son características socialmente construidas (normas, roles, relaciones) que influyen en los comportamientos y resultados de salud. • Estas características **varían entre sociedades y cambian con el tiempo**, y se diferencian del sexo biológico. • El género interactúa con otros factores (edad, etnia, nivel socioeconómico, orientación sexual, identidad de género), lo que genera **interseccionalidad** en las desigualdades y resultados de salud. (OMS, 2022)
Prestación de Servicios de Salud	Son las acciones directas frente al usuario, para restablecer, prevenir o tratar problemas de salud. En este sentido, los sistemas de salud en el mundo buscan optimizar la prestación en términos de atenciones sanitarias disponibles, suficientes, eficientes, y con calidad, garantizando el acceso a toda la población. (Departamento de Planeación Nacional, 2024)
Prevención de la enfermedad	Se refiere a la evaluación de los riesgos en la salud y el desarrollo de intervenciones que detengan el progreso de la enfermedad (Caron et al, 2023).
Prevención primaria	“Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes” (Julio, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011, p 12).
Prevención secundaria	“Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos “aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos (Pruebas de Screening).” (Julio, Álvarez y Sosa, 2011, p 12-13).
Prevención terciaria	“Se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente.” (Julio, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011, p 12-13)

Primer nivel de atención	Corresponde a los servicios básicos de salud que comprenden acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia y rehabilitación de menor complejidad, que se practiquen respecto de la familia en los ámbitos intradomiciliario, de consulta externa o ambulatoria general. Las acciones se orientarán a las personas y a su comportamiento en cuanto a la salud y al ambiente en el cual viven, permanecen, trabajan o se recrean (Caja Costarricense de Seguro Socia-Universidad de Costa Rica, 2003).
Procedimientos programados y no programados en psicología	Se refiere a la aplicación de instrumentos de medición psicológica, que apoyan el proceso de la atención psicológica. Estos se programan en SIAC en forma diferenciada de la consulta externa, pueden ser programados, uno a la vez, con antelación (mediante la cita a cupo de la persona usuaria), para realizar este procedimiento. El procedimiento no programado, se refiere a la aplicación de instrumentos, de acuerdo con la necesidad asociada a la condición de la persona usuaria (ya sea en la consulta externa u hospitalización), que hace impostergable su aplicación en un momento posterior.
Procesos de apoyo o soporte (Actividad Técnico logística)	Son todas aquellas actividades que desarrolla psicología para favorecer el cumplimiento de los procesos sustantivos, ya que generan los recursos requeridos para el soporte o apoyo de la atención psicológica. (Hernández, 2021)
Procesos misionales (en la CCSS)	Derivado de lo indicado en la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley Constitutiva de la CCSS, se puede indica que los procesos misionales de la CCSS se enfocan en la prestación de servicios de salud integrales y la protección económica, social y de pensiones a la población. Estos procesos se desarrollan con base en principios de universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad y equidad, buscando la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad financiera de la institución (CCSS, 2025)
Procesos sustantivos (Actividad sustantiva)	Conjunto de actividades afines, emanadas directamente de las atribuciones conferidas a una institución. (Biblioteca Digital de Seguridad Social [BIDISS], 2024). Para el caso de Psicología en la CCSS se circunscriben al proceso de la atención directa de las personas.
Profesional de salud	Profesional contratado y debidamente incorporado a su respectivo colegio (cuando corresponda), al cual se le asigna la programación de usuarios de acuerdo con el convenio contractual. La Jefatura de Servicio debe proporcionar los siguientes datos mínimos del profesional de salud para la programación de agendas: cédula, nombre completo, tipo de profesional (médico, odontólogo, otros), correo electrónico, especialidad, y código

	profesional, especialidades registradas (Caja Costarricense de Seguro Social, 2024a)
Promoción de la salud	Es un componente de la atención en salud, mediante el cual se generan los medios necesarios para lograr un empoderamiento, tanto individual como colectivo, por medio de la modificación de condiciones de vida de la población, mediante procesos de educación, comunicación, participación, el cual se enfoca en los factores protectores de la salud (Caja Costarricense de Seguro Social, 2019)
Psicoeducación	Se le puede definir como un proceso de educación terapéutica, en la cual se le brinda a la persona y a sus familiares o cuidadores, la información específica acerca de su enfermedad, tratamiento y pronóstico. Este proceso debe estar sustentados en metodologías basados en evidencia científica actual y relevante para el abordaje de la patología (Godoy, Eberhard, Abarca, Acuña y Muñoz, 2020).
Psicología	"La Psicología es una rama de la ciencia, que, se puede insertar en el campo de la salud, En este contexto aplica los principios, las técnicas y los desarrollos científicos construidos por esta disciplina, con el fin de desarrollar acciones técnicas en la promoción de la salud. También realiza procedimientos orientados a la prevención, la detección, la evaluación, la atención y la intervención-recuperación de las personas, que se ven afectadas por trastornos psicológicos (mentales y del comportamiento) o cualquier otra conducta que esté involucrada con los procesos de la salud y enfermedad, en los diferentes escenarios en los que puedan suceder. " (Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica, 2024; Colegio Oficial de Psicólogos, 2024).
Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS	“Un conjunto de establecimientos coordinados y articulados, que prestan servicios de salud en distintos ámbitos de complejidad, con responsabilidades asignadas y objetivos comunes, para asegurar el continuo asistencial de la población en un espacio geográfico y/o funcional, en un marco de mejoramiento continuo de la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad económica. Asume la responsabilidad clínica y económica en el logro de unos resultados de salud a la población que sirve y está dispuesto permanentemente a la rendición de cuentas de forma transparente” (Caja Costarricense de Seguro Social, 2020 p 30)
Referencia externa	Es la emitida por el profesional en salud de un establecimiento o área de salud, para que el consultante sea atendido en otro centro (Caja Costarricense de Seguro Social, 2018, p 14)

Reporte de aplicación de instrumentos de medición psicológicos	Es la integración de la información obtenida de la aplicación de uno o varios instrumentos de medición psicológicos, durante la atención psicológica, en el EDUS de la persona usuaria: Incluye la anotación, al menos de: datos generales encontrados, puntuaciones generales (ya sea de las variables principales) y conclusión interpretativa del procedimiento aplicado. *No se deben mantener informes paralelos*, es decir reportes en Word o papel en archivos físicos o electrónicos fuera del EDUS. Esto es fundamental para evitar omisiones de información en el SIES-EDUS de la persona usuaria.
Segundo nivel de atención	Apoya al nivel primario mediante la prestación de servicios preventivos, asistenciales y de rehabilitación con grado variable de complejidad y especialidad (Caja Costarricense de Seguro Social-Universidad de Costa Rica, 2003).
Sesiones clínicas técnicas	"Se refiere a las reuniones interdisciplinarias o unidisciplinarias donde, y con la presencia del expediente de salud del/la usuario/a atendida, se toman decisiones acerca del curso del proceso de atención integral de esta persona." (Caja Costarricense de Seguro Social, 2014, p 8).
Sistema de control interno	De acuerdo con la Ley General de Control Interno (Asamblea Legislativa, 2002), se entenderá por sistema de control interno (Artículo 8): (…) la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
Telepsicología	Proveer servicios psicológicos a distancia utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC), ya sea realizado de manera sincrónica (interactuando en tiempo real) o de forma asincrónica (intercambiando información de forma separada) (Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 2024, p. 6). Para efectos de psicología de la CCSS, se homologa esta modalidad de atención en los siguientes ámbitos de la telesalud: teleinterconsulta, teleconsulta, telesesión clínica, telesesión terapéutica y teleeducación para la salud, esto de acuerdo con los documentos emanados por el Área de Estadísticas de Salud y la Subárea Gestión de Telesalud, en sus versiones vigentes (Caja Costarricense de Seguro Social, 2024 y Caja Costarricense de Seguro Social, 2022)

Tercer nivel de atención	Corresponde a la prestación de servicios preventivos, asistenciales y de rehabilitación de la más alta especialización y complejidad, para atender determinados problemas de salud. El área de influencia del nivel terciario podrá trascender la del secundario y abarcar el territorio de varias provincias, cantones y distritos (Caja Costarricense de Seguro Socia-Universidad de Costa Rica, 2003).
Tipos de consulta	Categorías clasificatorias auxiliares en Consulta Externa (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2020)

Fuente: Elaboración propia

Referencias normativas

Leyes

- **Asamblea Legislativa. (1943).** *Ley N.°17: Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (1973).** *Ley N.º 5395: Ley General de Salud. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (1978).** *Ley N.º 6227: Ley General de la Administración Pública. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (1998).** *Ley N.º 7739: Código de la Niñez y la Adolescencia. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2002).***Ley N. ° 8220: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2002).** *Ley N. ° 8292: Ley General de Control Interno. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2012).** *Ley N. ° 9063: Ley Atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2013, fecha de modificación).** *Ley N. ° 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2018, fecha de reforma parcial).** *Ley N. ° 6144: Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2022).** *Ley N.º 10245: Ley de Cuidados Paliativos, Costa Rica. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*
- **Asamblea Legislativa. (2023).** *Ley N. °10412: Ley nacional de salud mental. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).*

Reglamentos y Políticas

- **Caja Costarricense de Seguro Social. Junta Directiva. (1999).** *Acuerdo de la Sesión N.º 7364, modificado en la Sesión N.º 8369: Expediente Único en Salud.*

- **Ministerio de Salud. (2001).** *Manual de Normas para el Control de Dolor y Cuidados Paliativos del I y II Nivel de Atención Médica* (Decreto Ejecutivo N.º 29561-S). Repositorio BINASSS.
- **Poder Ejecutivo. (2001).** *Reglamento para los Comités de Estudio de Niño, Niña y Adolescente Agredido* (Decreto Ejecutivo N.º 30007-S). Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Junta Directiva. (2018).** *Reglamento del Expediente Digital Único en Salud* (Sesión N.º 8954).
- **Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. (1979/2020).** *Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica* (Versión actualizada).
- **Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2023).** *Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023–2033 y su Plan de Acción* (Decreto Ejecutivo N.º 44257-MP-S-MTSS). UNFPA Costa Rica.
- **Ministerio de Salud. (2024).** *Plan de Promoción de la Salud 2023–2027* (2.ª ed., Código GM-8326-2024).

Documentos de regulación técnica institucionales

- **Caja Costarricense de Seguro Social. Junta Directiva. (2004).** *Normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales entre la CCSS y profesionales en medicina, microbiología, farmacia, odontología, psicología y otros* (Sesión N.º 7861).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2011).** *Lineamiento sobre los tiempos de consulta en la atención psicológica* (Código GM-18828-2, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2012).** *Lineamiento nacional sobre el rol de los servicios de psicología en relación con las evaluaciones psicológicas solicitadas como criterios técnicos para generar diagnósticos en las adecuaciones de acceso, adecuaciones curriculares no significativas y adecuaciones curriculares significativas* (Código GM-24535-2012, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2014).** *Manual de procedimientos de la Consulta Externa en Psicología* (Código GM-MDD-4508014, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. (2014)**. *Subproceso de prestación de servicios de psicología* (Código GM-MDA-2851-14 y sus actualizaciones).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2016).** *Manual de instrucciones de trabajo de atención psicológica de personas usuarias que acuden*

al Servicio de Urgencias (Código MIT.GM.DDSS-ARSDT-PSI.003, versión 00, aval GMMDD-16939-2016, versión actualizada).

- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2016).** *Manual de instrucciones de trabajo de atención psicológica de personas usuarias en el escenario domiciliar* (Código GM-MDD-20462-2016, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2017).** *Lineamiento de contenido estándar para las anotaciones de psicología en la hoja de evolución del Expediente de Salud (EDUS)* (Código GM-MDD-32335-2017, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2018).** *Manual para la gestión de los servicios de Consulta Externa en el marco de un plan de atención oportuna* (Código GM-UTLE-CPE-14718-2018, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. (2018).** *Oferta de servicios especiales de psicología. Volumen 1* (Código GM-DESP-15927-2018, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2020).** *Lineamiento para la definición y creación de tipos de consulta en Psicología en el Sistema Integrado de Agendas y Citas (SIAC)* (Código L-GM-DDSS-ARSDT-PSI-05112020 / GM-16837-2020, versión actualizada)
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2020).** *Manual de procedimientos para la aplicación de la Telepsicología en la Caja Costarricense de Seguro Social* (Código MP-GM-DDSS-ARSDT-PSI-11112020 / GM-2741-2020, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. (2020). *Oferta de servicios especiales de psicología* (Versión 2, GM-MDD-0190-2020 y sus actualizaciones).**
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2021).** *Lineamiento sobre la oficialización de la lista de instrumentos de medición psicológicos (LOIMP) y procedimiento para la inclusión de nuevos instrumentos* (Código GM-17016-2021, versión actualizada)
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2021).** *Lineamiento para la compra de instrumentos de medición y evaluación psicológicos en los establecimientos de salud de la CCSS* (Código GM-0059-2021, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2022).** *Instrumento de Supervisión Integrado de Psicología para los tres niveles de atención (ISIP)* (Código GM-15373-2022, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2024).** *Instrucción de Trabajo para la atención psicológica de las personas que se encuentran en servicios*

de hospitalización de la CCSS (Código IT.GM.DDSS-ARSDT-PSI.02, versión 02, GM-7371-2024).

- **Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica. (2024).** *Lineamiento para la prestación de servicios en Promoción de la Salud para niñas, niños y adolescentes en el primer nivel de atención* (Código L.GM.DDSS-ASC-PS.170723 / GM-15297-2024, versión actualizada).
- **Caja Costarricense de Seguro Social. (2024).** *Medida temporal para el desarrollo de proyectos, programas o iniciativas institucionales en Territorios Indígenas, acorde al Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas* (Decreto Ejecutivo N.º 40932-MP-MJP, Código GG-1154-2024, versión actualizada).

Abreviaturas:

- CCSS/Caja: Caja Costarricense de Seguro Social.
- CIE-10 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud. Edición 10.
- CNP: Coordinación Nacional de Psicología.
- DDSS: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.
- DNT: Documento de normalización técnica.
- DRIPSS: Dirección integrada de prestación de Servicios de Salud.
- EDUS: Expediente Digital Único en Salud.
- GIT: Grupos integrados de trabajo.
- OMS: Organización Mundial de la Salud.
- OPS: Organización Panamericana de la Salud.
- PAC: Protocolo de Atención Clínica.
- PME: Persona menor de edad.
- RIPSS: Red integrada de prestación de Servicios de Salud.
- SIAC: Sistema integrado de agendas y citas.
- SIES: Sistema Integrado de Expediente de Salud.

Alcance y campo de aplicación

Este documento de regulación define las pautas de gestión y la oferta de las prestaciones de servicios psicológicos en la CCSS vinculado explícitamente con el Proceso Sustantivo PM-02, derivados de la atención integral de la salud psicológica (promoción de la salud, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción), acorde con el nivel de complejidad de las personas que son atendidas en psicología de todos los establecimientos de salud de la institución, que brindan atención directa en los tres niveles de atención, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud y en el Nivel Central, de acuerdo con lo estipulado con la normativa institucional.

El actual DNT es el fundamento para cualquier programa de atención integral que involucre a Psicología; esto es, dichos programas solo podrán implementarse en lo tocante a esta disciplina, si atienden a las regulaciones de la gestión técnica aquí indicadas.

El presente documento debe ser utilizado y aplicado, por todos los profesionales en psicología que realicen atención directa a personas usuarias en los establecimientos de salud, en los tres niveles de atención y en el Nivel Central. Así mismo, su ámbito de aplicación abarcará a los diferentes escenarios como consulta externa, hospitalización, servicios de emergencias y otros entornos fuera de los establecimientos de salud autorizados en la CCSS para la actividad de atención psicológica en la Institución.

Las modificaciones y actualizaciones de los contenidos de este documento (cuando correspondan), son competencia de la Coordinación Nacional de Psicología, las cuales se realizarán mediante las metodologías regulatorias institucionales vigentes y dichos cambios deben ser avalados por la Gerencia Médica para su implementación oficial.

Objetivo General

Regular las actividades de psicología, en los tres niveles de atención y en Nivel Central, de acuerdo con el Proceso Misional “Prestación de Servicios de Salud”, para el fortalecimiento de los procesos de gestión disciplinar en los establecimientos de salud de los tres niveles de atención de la CCSS, mediante la implementación del presente Manual en la prestación de los servicios.

Objetivos específicos

1. Normar las funciones institucionales propias de la disciplina de psicología, para la planificación de la gestión local de la prestación de servicios en los tres niveles de atención, de acuerdo con el proceso misional de la CCSS y el Modelo de Atención en Salud vigente.

2. Definir las actividades sustantivas de la disciplina de psicología en los tres niveles de atención y el Nivel Central, según la estructura organizacional de la CCSS en su nivel estratégico, táctico y operativo, de conformidad con el Modelo de Atención en Salud vigente.

Responsable del cumplimiento

En los cuadros 2 y 3 se exponen los responsables de cumplimiento y los encargados de verificar el cumplimiento de este DNT; respectivamente.

Cuadro 2.

Unidades y su responsabilidad

Puestos de trabajo	Responsabilidad
Profesionales de psicología del nivel local (establecimientos de salud de los tres niveles de atención)	Implementar las regulaciones, actividades y gestiones contenidas en este DNT durante la jornada laboral.

Fuente: Elaboración propia

Responsable de verificar el cumplimiento

Cuadro 3.

Unidades y su responsabilidad

Puestos de trabajo	Responsabilidad
Dirección general o Dirección Médica	Monitorear la implementación de los contenidos y regulaciones de este Manual.
Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud (supervisiones de acuerdo con el Instrumento de Supervisión Integrado de Psicología vigente)	Verificar mediante supervisiones y seguimientos regulares, la correcta implementación de las regulaciones contenidas en este DNT.
Jefatura directa de psicología	Verificar que los profesionales de psicología realicen la implementación de los contenidos de este DNT.
Coordinación Nacional de Psicología	Verificar mediante supervisiones o asesorías, la correcta implementación de las regulaciones contenidas en este DNT. Brindar asesoría técnica a las DRIPSS, o jefaturas directas de psicología sobre los contenidos de este Manual.

Fuente: Elaboración propia

Contenido

Ubicación Contextual

La actividad psicológica en la CCSS se ubica como parte de las ciencias de la salud, de acuerdo con el Modelo de Atención en Salud vigente, y basados en la autonomía de gobierno de los seguros de salud, que la Constitución Política de Costa Rica le confiere a la CCSS, se puede enunciar la participación de psicología en una serie de dimensiones asociadas a salud y enfermedad. El cuadro 4, permite evidenciar el rol de la psicología en la CCSS, que se organiza dentro de un amplio espectro de actuación en salud y enfermedad.

Cuadro 4.

Acciones sustantivas asociadas a la participación de psicología, de acuerdo con el Modelo de Atención en Salud, en la CCSS y por Nivel de Atención.

	Establecimientos de salud					
Actividades sustantivas	**Áreas de Salud tipo I**	**Áreas de Salud tipo II[a]**	**Áreas de Salud tipo III[b]**	**Hospitales Periféricos y Regionales**	**Hospitales Nacionales**	**Hospitales y Centros Especializados**
Promoción de la Salud	Sí	Sí	Sí	--	--	--
EFES comunitario	Sí	Sí	Sí	--	--	--
EFES[c] laboral	Sí	Sí	Sí	--	--	--
EFES domiciliar[d]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
EFES educativo	Sí	Sí	Sí	--	--	--
Prevención Primaria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prevención Secundaria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prevención Terciaria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración Propia

Notas: en la sección de Definiciones, abreviaturas y símbolos, aparecen los conceptos asociados a la tabla. [a] y [b] Solo se participará en los procesos de Promoción de la Salud cuando las Áreas de Salud tipo II y III tengan EBAIS a su cargo, [c] Escenarios fuera del establecimiento de salud (EFES), [d] De acuerdo con el

Manual de instrucciones de trabajo de atención psicológica de personas usuarias en el escenario domiciliar (GM-MDD-20462-2016), Psicología de la CCSS solo puede realizar esta actividad para la atención directa de personas usuarias con patología oncológica o de tipo benigno en fase terminal, así como en cuidados paliativos-dolor crónico en fase avanzada (sin embargo estas actividades también se realizan dentro de los establecimientos de salud, en los tres Niveles de Atención).

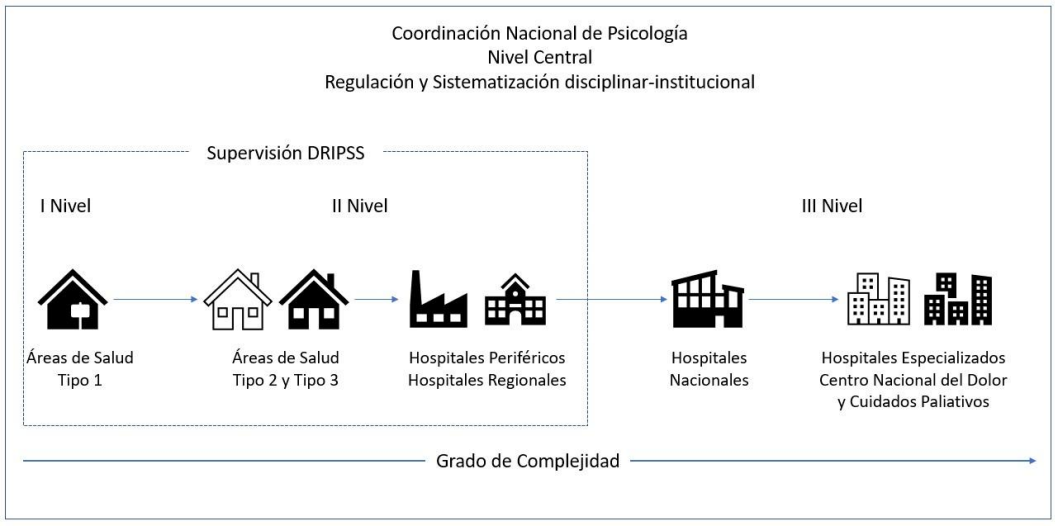
Gestión de la actividad de psicología en la CCSS

Si bien la actividad de psicología de la CCSS, se inserta dentro los procesos mencionados en el cuadro 4, se debe articular un sistema de gestión que permita organizar y administrar los recursos, actividades y personal, permitiendo la maximización y la posibilidad de mejora en la salud psicológica y disminución de la enfermedad.

Para el logro de lo anterior se debe organizar un sistema de gestión en psicología, a lo largo de los tres niveles de atención, que permita la articulación de las diferentes actividades en las que interviene psicología (cuadro 4). De esta forma, se puede retomar la siguiente figura 1:

Figura 1.

Esquema de la organización funcional de la disciplina de Psicología en la CCSS.



Fuente: Área de Estructuras Organizacionales, 2024.

La organización funcional de los establecimientos de salud, en general, de la CCSS, siguen una línea de complejidad, indicada en la Figura 1, (ver definición en la sección de Definiciones), creciente que va desde: a) los EBAIS y las áreas de salud

tipo 1 y 2 (primer nivel de atención); b) las áreas de Salud tipo 3, los hospitales periféricos (1, 2 y 3) y los hospitales regionales (segundo nivel de atención) y, c) el tercer nivel de atención está constituido por los hospitales nacionales generales y especializados.

Por lo anterior, la prestación de servicios en psicología se debe realizar en red, de manera que un profesional en psicología siempre debe de tener presente que de acuerdo con la complejidad del diagnóstico de la persona usuaria puede contar con apoyo de unidades más especializadas. Lo mismo aplica para el personal de unidades más complejas en lo que respecta a la contrarreferencia y seguimiento de las personas usuarias hacia establecimientos de salud menos complejos.

Dentro del ámbito de la promoción de la salud, los profesionales de psicología también se insertan como un recurso valioso en la consolidación y fortalecimiento de los factores protectores de salud, a la luz y de acuerdo con las regulaciones vigentes en la materia (revisar en la sección Referencias Normativas los documentos institucionales relativos a este punto). Estas actividades, como se ha indicado previamente solo se realizarán en el I Nivel de Atención, salvo las excepciones contenidas en el cuadro 4.

A su vez los profesionales de psicología que realizan labores asistenciales en los tres niveles de atención podrán participar en diversas actividades de prevención primaria (tipo psicoeducación, por ejemplo, pero no solo limitado a este modelo), de acuerdo con parámetros que se definirán más adelante.

Gestión procesual de las actividades de psicología en la CCSS

Con el fin de facilitar y fortalecer las actividades de psicología en la CCSS, se han definido acciones que, están orientadas a fortalecer los factores protectores de la salud psicológica y, hasta donde sea posible, disminuir los factores de riesgo en salud, sin dejar de lado las acciones de tratamiento, cura, rehabilitación y reinserción (que deben ocurrir a lo largo de toda la Red).

De esta forma, en la Institución se impulsa la organización por procesos, los cuales se dividen en: sustantivos, complementarios y de apoyo.

- Los procesos sustantivos son aquellos que determinan la razón de ser de cada unidad organizacional. Son aquellos que por competencia técnica son responsabilidad única de la unidad organizacional. Son los que representan el mayor valor agregado para el usuario y, que son clave para cumplir con la misión y visión institucional. De los procesos sustantivos se derivan, como es el caso de la Psicología de la CCSS, los subprocesos de la disciplina, que

incluyen las características anteriores y son pertinentes a la ciencia de la salud correspondiente. En el caso de Psicología de la CCSS, las acciones sustantivas se orientan a promoción de la salud (en el I Nivel de atención) y atención psicológica (en todos los niveles de atención).

- Los procesos complementarios son aquellos que no siempre se deben realizar, pero que cuando se realizan, añaden valor al producto o proceso sustantivo. Para el caso de Psicología, participación en grupos de trabajo que no están vinculados a la atención de personas usuarias, llenado de documentos remitidos desde el Nivel Central, entre otros.

- Los procesos de apoyo son aquellos que permiten conducir las acciones y gestionar los recursos administrativos, logísticos y tecnológicos para la correcta ejecución de las funciones, productos y procesos sustantivos y complementarios.

De esta forma, el actual subproceso de la disciplina de Psicología responde al modelo de atención que rige en la actualidad para la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social, 2014), que ejecuta la red de servicios de salud y procura incorporar los diferentes componentes de salud, que son necesarios para la conducción de las actividades y tareas susceptibles de implementación por la psicología institucional.

Es claro que, si nos remitimos al cuadro 4, se puede contemplar la amplia distribución de espacios organizacionales en salud, dentro de los cuales se inserta la actividad psicológica institucional. Esta diversa participación de la disciplina requiere la articulación dentro de marco regulatorio y normativo, que permita una efectiva y eficiente conducción de los procesos y procedimientos asociados en el diario accionar de la psicología, como parte de los servicios de apoyo de la Institución.

Definición de la actividad de psicología en la Institución

La disciplina de psicología tal y como se han mencionado en secciones precedentes, organiza sus actividades a lo largo de los tres niveles de atención, orientándose a la prestación de servicios de salud centrada en las personas usuarias, enfoque de derechos, interculturalidad, con visión de sensibilidad de género y de poblaciones vulnerables, atendiendo lo que es propio de su ámbito de conocimiento y técnica, pero también se inserta en programas, ofertas de servicios, comisiones y equipos de trabajo para fortalecer el efecto de las intervenciones en las personas usuarias.

El cuadro 4 decanta las acciones principales en las que se inserta psicología. Algunas de estas actividades pueden desarrollarse mediante comisiones (ver definición en la sección Definiciones) y Grupos Integrados de Trabajo (GIT). Los GIT son equipos funcionales conformados por profesionales y técnicos de diversas disciplinas en el campo de la salud, de acuerdo con los requerimientos y programas de atención a las personas que desarrollan los establecimientos de salud. Se aclara que los GIT no son comisiones, sino equipos funcionales que se activan o descontinúan ante un requerimiento puntual, así aprobado por las autoridades institucionales o las direcciones médicas y generales.

Descripción del Componente de Psicología en la Institución

A nivel Institucional se puede caracterizar a la psicología como una ciencia de la salud, que aplica los principios, las técnicas y los desarrollos científicos construidos por esta disciplina, con el fin de desarrollar acciones técnicas en diversos escenarios de salud y atención de enfermedad contemplados en el cuadro 4.

Para el logro de lo anterior, la Psicología ha desarrollado sus propios mecanismos teóricos y metodológicos, para fortalecer condiciones de salud (promoción de la salud) y, abordar, tratar y recuperar las diferentes alteraciones del comportamiento humano (dimensión preventiva, tratamiento, cura, rehabilitación y reinserción).

La Psicología de la CCSS, lleva a cabo las actividades contempladas anteriormente mediante un modelo de atención de salud pública centrado en las personas usuarias, con una visión de carácter integral, que procura según las posibilidades y recursos cognitivos, emocionales y conductuales, una respuesta funcional y crítica de las personas usuarias en sus ámbitos de vida, educación, trabajo, comunidad, entre otros (Colegio Oficial de Psicólogos, 2024; Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica, 2024).

Estas acciones se desarrollan de manera diferenciada según el nivel de atención, tipo de establecimiento de salud y escenario definido, lo que implica la utilización de diferentes técnicas y procedimientos psicológicos basados en evidencia científica, según el nivel de complejidad, aplicación de técnicas, procedimientos y modalidades específicas, en forma unidisciplinaria o en Grupos Integrados de Trabajo (GIT) debidamente avalados por las autoridades institucionales.

Lo anterior permite y fortalece la planificación de las actividades, la participación en programas especializados, el seguimiento y la evaluación integral de las acciones, con fundamento en documentos de normalización técnica, metodologías de trabajo y líneas de acción emitidas por la instancia institucional competente y con el aval gerencia correspondiente.

Para el logro de lo anterior, este Manual de Gestión sigue la línea organizacional que permite establecer varias agrupaciones de establecimientos de salud, las cuales se incluyen dentro de los niveles de atención y representan ámbitos de abordaje de la salud y enfermedad, propios de su espectro de acción.

Áreas de Salud (tipo I; II y III),

En el ámbito de las Áreas de Salud, se agrupan actividades como la promoción de la salud (áreas de salud I y las áreas de salud II y III, que tienen a cargo EBAIS), la prevención primaria y acciones clínicas de tipo ambulatorio.

El eje de promoción de la salud se orienta al fortalecimiento de los de estilos de vida saludables, mediante el desarrollo de los diferentes ejes normados a nivel institucional.

La intervención psicológica en este nivel se orienta a la detección temprana y al tratamiento oportuno de la persona usuaria, con el fin de disminuir la prevalencia de la enfermedad, haciendo uso de las diferentes modalidades definidas y en programas específicos que promueven la identificación temprana de los problemas asociados al bienestar psicológico. Lo que involucra acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación psicológica en la consulta externa y cuando corresponda, la participación en escenarios fuera de establecimientos de salud (EFES).

Hospitales periféricos y regionales

Los hospitales periféricos se caracterizan por agrupar actividades médicas y quirúrgicas de mediana complejidad en el segundo nivel de atención, mediante acciones de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción desde la perspectiva física, psicológica y social.

Los hospitales regionales son establecimientos de salud que incluyen a especialidades médicas y quirúrgicas medianamente complejas (revisar el concepto de complejidad en la sección de Definiciones), propias de un segundo nivel de atención, mediante el correcto diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción desde la perspectiva física y psicológica, así como con la participación de otras profesiones.

La intervención psicológica en este nivel se orienta al abordaje y tratamiento, así como la disminución de la prevalencia de la enfermedad, en las diferentes modalidades definidas y en programas específicos que promueven la identificación

de los problemas asociados a la salud psicológica. Se desarrollan actividades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción psicológica en el ámbito de la consulta externa, emergencias, hospitalización y los escenarios fuera de establecimientos de salud que se definan para este nivel de atención y ofertados por profesionales de psicología formados y entrenados en el abordaje de este nivel de complejidad.

Como actividades fundamentales, pero no exclusivas de estos establecimientos, pueden realizar lo siguiente:

- Desarrollo de funciones sustantivas con apoyo transversal a los Servicios Médicos y Quirúrgicos del centro hospitalario y colaboración multidisciplinaria con otras profesiones.

- Coordinación interniveles (con el Primer y Tercer Nivel de atención), de acuerdo con las características anteriormente descritas

- Atención de la persona usuaria en la consulta externa, emergencias y hospitalización y escenarios fuera de establecimientos de salud aprobados para este tipo de establecimiento.

- Participación interdisciplinaria en equipos y programas hospitalarios avalados para estos establecimientos.

- Gestión eficiente de los recursos requeridos para garantizar una prestación de servicios confiable y eficiente, de cara a las personas usuarias.

Hospitales Nacionales, Hospitales Especializados y Centros Especializados

Se agrupan aquí los establecimientos con especialidades y subespecialidades propias de un Tercer Nivel de Atención, para el abordaje de patologías que por su complejidad requieren atención y procedimientos especializados ofertados por profesionales de psicología formados y entrenados en el abordaje de este nivel de complejidad, además son ámbitos institucionales que incluyen alta tecnología, orientada a la recuperación integral de la salud, mediante el correcto diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción de las condiciones de salud psicológica de la persona usuaria, todo lo anterior en cooperación con otras profesiones.

Desde la perspectiva de la psicología el accionar se orienta a minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de las personas a los problemas crónicos y malignidades, contribuir desde el punto de vista psicológico a prevenir o reducir al máximo las recidivas de la enfermedad. Desarrolla

sus intervenciones en el ámbito de la consulta externa, emergencias y atención intrahospitalaria.

Estos establecimientos y su personal tienen una cobertura nacional y pueden participar en GIT de programas altamente especializados, de acuerdo con la oferta avalada para la profesión y escenarios fuera de los establecimientos de salud que se definan para este nivel.

Los establecimientos de salud del III Nivel, abarcan dos grandes tipos de abordajes:

1. Hospitales Nacionales: atención en consulta externa por referencia externa (desde el II Nivel), referencia interna (desde programas especializados u ofertas especiales avaladas, en ambos casos, por la Gerencia Médica), interconsulta (hospitalización o emergencias).

2. Hospitales y centros especializados: atención en consulta externa por referencia externa (desde el III Nivel), referencia interna (desde programas especializados u ofertas especiales avaladas, en ambos casos, por la Gerencia Médica), interconsulta (hospitalización y emergencias), en los ámbitos propios de su actividad hospitalaria.

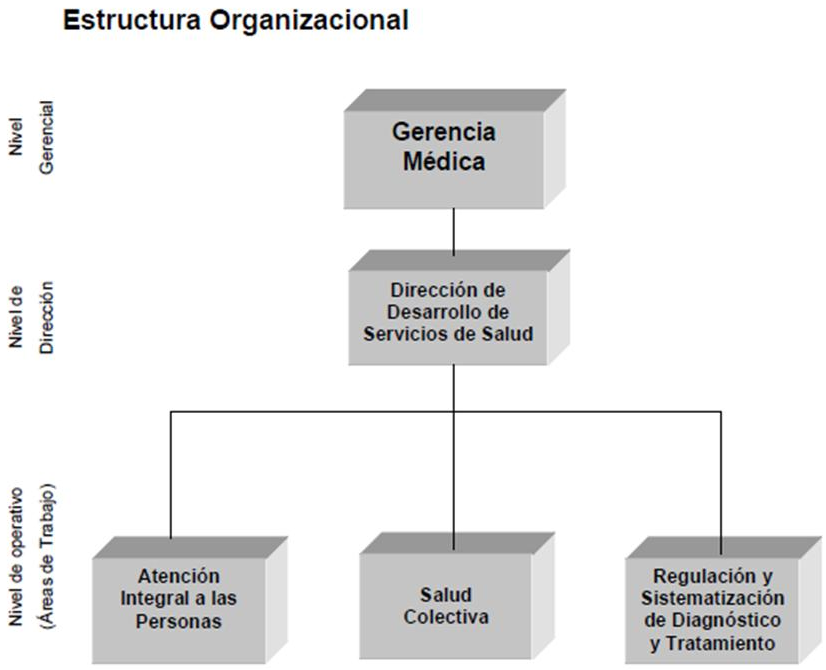
Conformación de las prestaciones de servicios psicológicos a las personas usuarias

La prestación de servicios psicológicos en la CCSS se gestiona con los profesionales contratados por Institución, para la atención de las personas usuarias.

Según el documento titulado “Actualización de Análisis General Evaluativo de la Reestructuración Organizacional de la Gerencia Médica y la elaboración de los Manuales de Organización específicos de las Direcciones adscritas”(2008), la Coordinación Nacional de Psicología se encuentra ubicada dentro del Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, adscrita a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Gerencia Médica de la CCSS, según se detalla en la siguiente imagen.

Figura 2:

Esquema Estructura Organizacional



Fuente: Análisis General Evaluativo de la Reestructuración Organizacional de la Gerencia Médica 2008

Esta unidad tiene como función principal brindar asesoría, evaluación, y la elaboración de documentos de normalización técnica para la atención directa de las personas en la promoción, prevención, curación, rehabilitación de la salud, donde su campo de acción y población meta abarca los tres niveles de atención en salud.

Oferta de servicios psicológicos en los tres niveles de atención de la Caja

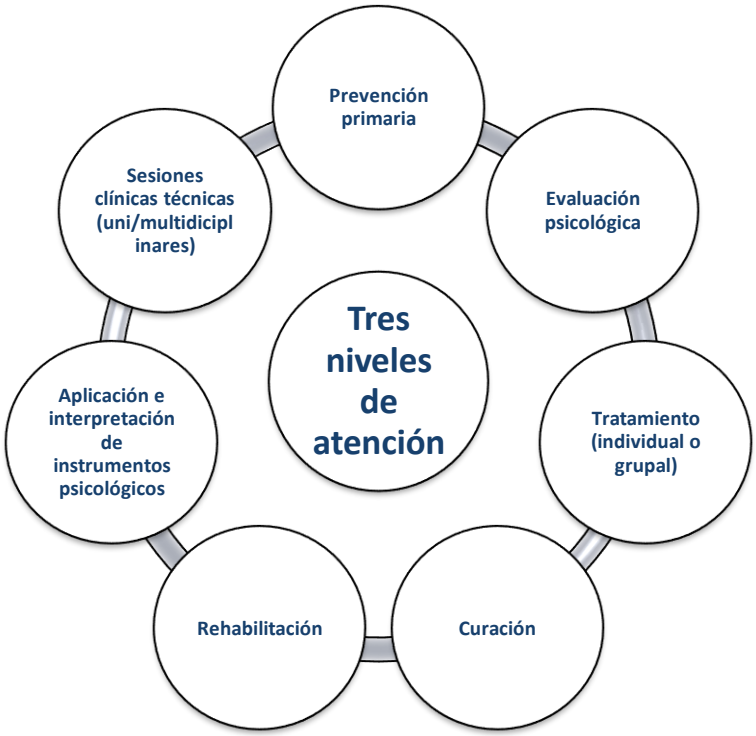
La prestación de servicios de salud por parte de psicología de la CCSS se orienta a los siguientes ejes: promoción de la salud (revisar los documentos normativos institucionales para conocer la actuación de psicología en este tema), prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, en los distintos escenarios y modalidades avaladas por la CCSS, para tales efectos.

Es importante aclarar que y, de previo a la descripción de la oferta de servicios de psicología, el concepto de atención psicológica se ha ampliado, con el fin de que los profesionales de psicología puedan tener la holgura para la planificación de sus actividades a lo largo de un espectro de actuación técnica. Si bien su

conceptualización se puede observar en la sección de Definiciones, la siguiente figura 3 permite observar de manera más comprensiva sus vertientes:

Figura 3.

Representación gráfica del concepto de Atención Psicológica



Fuente: Elaboración propia

Notas. Conceptos como prevención primaria, evaluación psicológica y sesiones técnicas, pueden ser ubicadas en la sección de Definiciones de este documento.

Es importante aclarar que las actividades de psicología, como la atención psicológica se organizará en el contexto del subproceso de atención integral de psicología, solo puede ser realizada única y exclusivamente por profesionales de psicología con nombramiento activo en la Institución.

Con el fin de ilustrar con mayor detalle la participación de la disciplina de psicología, en los diferentes niveles y establecimientos de salud, se presenta el cuadro 5. Se acota que lo correspondiente a capacitaciones y otras actividades contempladas en las *Normas que rigen las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales, entre la CCSS y profesionales en medicina,*

microbiología, farmacia, odontología, psicología y otros, se deben programar de previo a la planificación de lo indicado en el cuadro 5, de tal forma que ya estén contempladas de previo a la programación anual de actividades. En ese mismo sentido, rubros como vacaciones, permisos, alimentación y otros derivados de acciones que se pueden planificar previamente a las programaciones anuales, deben ser contempladas previo a la programación para actividades sustantivas y complementarias/apoyo.

Cuadro 5.

Distribución de las actividades sustantivas y complementarias de psicología para el I, II y III Nivel de Atención.

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad sustantiva</th><th>Actividad complementaria</th></tr>
<tr><td colspan="2">Participación en proyectos de promoción de la salud de las Comisiones Locales de Promoción de la Salud (actividad exclusiva del área de salud tipo I y de las áreas de salud tipo II y III que tienen EBAIS a su cargo)</td><td rowspan="6">Actividades técnico-logísticas (ingreso de resultados de pruebas al EDUS, elaboración de materiales para talleres o sesiones psicoterapéuticas, clasificación de referencias, actividad de enlace del servicio, participación en otros equipos donde psicología no es parte de la plantilla oficial[1], entre otros).</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Atención psicológica (incluye el llenado de EDUS en tiempo real)</td><td>Consulta externa (en las diferentes modalidades y escenarios avalados por la CCSS)</td></tr>
<tr><td>Interconsulta para atención intrahospitalaria</td></tr>
<tr><td>Interconsulta para atención en servicio de Urgencias / Emergencias</td></tr>
<tr><td>Procedimiento de evaluación psicológica: aplicación, calificación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos para la consulta externa o interconsultas</td></tr>
<tr><td>Sesiones clínicas técnicas</td></tr>
</table>

[1] Se recomienda evitar la inclusión de los profesionales de psicología en equipos de trabajo, donde esta disciplina no es parte de las plantillas oficiales avaladas por la Gerencia Médica, ya que ello afecta el uso efectivo del tiempo profesional en los procesos sustantivos de la disciplina, enmarcados en el proceso misional de la CCSS.

	Prevención primaria (por ejemplo: charlas, talleres, entre otros)	
Comisiones y grupos integrados de trabajo (equipos) para actividades en salud debidamente avalados por la Institución.	Participación en Comisiones con aval de Autoridades, donde psicología es parte de la plantilla (por ejemplo: Violencia, CEINNA; Salud Mental)	
	Grupos integrados de trabajo (equipos), donde psicología es parte de las plantillas oficiales avaladas por la Gerencia Médica, ley o decreto ejecutivo para aspectos relacionado con salud y enfermedad. La jefatura debe tener por escrito, desde el Nivel Central si psicología es parte de la plantilla, de otra forma no deberá participar esta disciplina en equipos que afecten la provisión de servicios de salud en consulta externa, hospitalización o urgencias/emergencias a las personas usuarias. Psicología no debe ser integrado en equipos como GEVI; GAT y otros de carácter local, pues no incluyen a esta disciplina como parte de su plantilla.	

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 6 se desglosa la distribución de las actividades señaladas en el cuadro 5, por cada tipo de establecimiento de salud.

Cuadro 6.

Distribución de las actividades sustantivas y complementarias, para los servicios de psicología, por tipo de establecimiento de salud.

Nivel	Establecimiento	Actividad								
		Sustantiva								Complementarias
		Promoción de la salud[a]	Prevención primaria[b]	Consulta externa[c]	Interconsulta	Aplicación, calificación e interpretación de inst. de medición psicológicos	Sesiones clínica técnicas	Comisiones oficiales	Equipos oficiales	
I Nivel	Áreas de Salud tipo I	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Áreas de Salud tipo II	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
II Nivel	Áreas de Salud tipo III	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Hospital Periférico	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Hospital Regional	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
III Nivel	Hospital Nacional	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Hospital o Centro Especializado	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: elaboración propia, 2025.

Notas: [a], [b], [c], estas actividades se pueden realizar en las instalaciones del establecimiento de salud y en los Escenarios Fuera del Establecimiento de Salud indicados en el cuadro 4.

En relación con las actividades que norma el Área de Atención Integral a las Personas, por ejemplo: Programa del Niño, Adolescente, Mujer, Adulto Mayor, Violencia, entre otros, se procederá a implementar lo avalado por la Gerencia Médica para cada caso y, en especial el apartado relacionado con la atención psicológica que haya sido construida por la Coordinación Nacional de Psicología en los documentos normativos que hayan emitido esos programas.

Descripción de actividades

En este apartado se desglosa, por tipo de establecimiento de salud, los diferentes ámbitos de inserción avalados para la disciplina de psicología en la CCSS, se indican los porcentajes generales de programación anual del servicio.

Se deben planificar tanto las actividades sustantivas, las complementarias y todos aquellos aspectos relacionados con las *Normas que regulan las relaciones laborales*, con el fin de establecer la programación completa anual. De esta forma, se podrá tener un mapa de las acciones que anualmente realizará el servicio.

Esta planificación se debe hacer con el total de horas programadas de los funcionarios de psicología (con nombramiento activo en los perfiles de puestos de psicología vigentes y avalados por la Dirección de Administración y Gestión de Personal – DAGP). Por ejemplo, si un establecimiento tiene dos profesionales de psicología o más, debe generar un plan de trabajo y programación con el total de tiempo de todos los colegas. Por ello se recomienda que todos los profesionales de la disciplina sean integrados en un único equipo de psicología que brinden la oferta de servicios.

Áreas de Salud tipo I, II y III

Estos establecimientos de salud abarcan los niveles de complejidad tipo bajo (áreas de salud I) y medio (áreas de salud tipo II y III), se orientan a procesos de promoción de la salud y prevención primaria y secundaria, en las alteraciones psicológicas de personas usuarias que son referidas o contrarreferidas a estos centros. En el cuadro 7 se describen las prestaciones de servicios en salud psicológicas definidas para estos establecimientos.

Cuadro 7

Descripción de las prestaciones de servicios de salud en las áreas de salud tipo I, II y III.

Establecimiento	**Actividad**								**Total**
	Sustantiva							***Complementarias - Apoyo***	
	Promoción de la salud	Atención psicológica[a]							
		Prevención primaria	Consulta externa	Aplicación, calificación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos	Sesiones clínicas técnicas	Comisiones oficiales	Equipos oficiales		
Áreas de Salud tipo I	10%	75%						15%	100%
Áreas de Salud tipo II	10[b]	75%						15%	100%
Áreas de Salud tipo III	10[c]	75%						15%	100%

Fuente: Elaboración propia

Notas: [a] El continuo del concepto Atención psicológica, permite que el establecimiento de salud programe cada rubro, no obstante la prioridad deberá ser siempre sin excepción la prestación directa de servicios psicología en la Consulta Externa, para el resto de los rubros su programación siempre será inferior a la consulta externa y debidamente justificado y aprobados por la jefatura de Consulta Externa. [b], [c] Las Áreas de Salud tipo II y III, realizarán acciones de promoción de la salud, de acuerdo con lo normado institucionalmente, cuando sus establecimientos tengan EBAIS a su cargo.

En el cuadro 8 se presenta un desglose de las tareas mínimas que debe realizar el profesional de psicología contratado en las Áreas de Salud tipo I, II y III para cada una de las actividades sustantivas y complementarias planificadas y ofertadas.

Cuadro 8.

Desglose de tareas mínimas esperadas y modalidades de atención recomendadas para las actividades sustantivas y complementarias realizadas en las Áreas de Salud tipo I, II y III.

Actividades sustantivas	Actividades complementarias / Apoyo	Tareas mínimas esperadas	Modalidades de atención
Participación en proyectos de promoción de la salud de las Comisiones Locales de Promoción de la Salud		Las señaladas por las regulaciones de Promoción de la Salud, al menos involucra diseño de plan, aplicación y recolección de información.	Grupos abiertos Charlas
Prevención primaria		Diseño de actividad Desarrollo de actividad de prevención primaria según temática epidemiológica. Redacción de reporte de la actividad (incluye evidencias como listas, fotos y otros).	Grupos abiertos no terapéuticos
Atención Consulta Externa		-Entrevista inicial con la persona usuaria. Firma o lectura de consentimiento. Desarrollo de los objetivos terapéuticos. Realización de las sesiones de intervención, según objetivos terapéuticos. Alta, de acuerdo criterio del profesional y cumplimiento de objetivos terapéuticos. Anotación permanente en el EDUS del usuario.	Individual Grupal terapéutica unidisciplinaria (se debe favorecer esta opción cuando la población tenga las características clínicas que lo permitan y es un criterio del profesional de psicología el que define su apertura). Familia o pareja
Procedimiento de evaluación psicológica: aplicación de instrumentos de medición psicológicos		Agendamiento del procedimiento de evaluación a través de los instrumentos de medición psicológica. Anotación en el EDUS de los resultados	Individual o grupal (según el manual del instrumento de medición).

para la consulta externa		Comunicación a la persona usuaria sobre los resultados en espacios la consulta externa.	
Sesiones clínica técnicas		Revisión de casos de personas usuarias en modalidades inter o unidisciplinarias Anotación en EDUS, según el perfil correspondiente.	Grupos profesionales de análisis de información
Comisiones y grupos integrados de trabajo (GIT-equipos), con aval de Autoridades, donde psicología es parte de la plantilla (Violencia, CEINNA; Salud Mental)		Lo definido en los documentos de normalización o regulatorios avalados por la Gerencia Médica para este efecto	No aplica
	Actividades técnico-logísticas	Algunos ejemplos, pero no son exhaustivos: llenado de documentos administrativos solicitados por diferentes autoridades institucionales, integración de cuadros estadísticos y la atención de supervisiones disciplinarias, docencia, investigación, ingreso de resultados de pruebas al EDUS, elaboración de materiales para talleres o sesiones psicoterapéuticas, clasificación de referencias entre otras.	No aplica

Fuente: Elaboración propia

Nota: las celdas en color verde no contienen información para esa actividad.

Hospitales regionales y periféricos

Incluye a los establecimientos de salud hospitalarios del II Nivel de Atención, con complejidad media y alta, que se orientan a la atención de condiciones que, por el agravamiento de los síntomas psicológicos requieren una intervención de mayor especialización.

En el cuadro 9 se describen las prestaciones de servicios en salud psicológicas definidas para estos establecimientos.

Cuadro 9

Descripción de las prestaciones de servicios de salud en los hospitales periféricos y regionales del II Nivel.

Establecimientos	**Actividad**						**Total**
	Atención psicológica[a]					Complementaria	
	Prevención primaria	Consulta externa	Interconsulta (hospital y emergencias)	Aplicación, calificación, interpretación de instrumentos de medición psicológicos	Sesiones clínicas técnicas	Comisiones y equipos oficiales	
Hospital periférico	85%					15%	100%
Hospital Regional	85%					15%	100%

Fuente: Elaboración propia

Notas: [a] El continuo del concepto Atención psicológica, permite que el establecimiento de salud programe cada rubro, no obstante, la prioridad deberá ser siempre sin excepción la prestación directa de servicios psicología en la Consulta Externa, hospitalización y emergencias, para el resto de los rubros su programación siempre será inferior a los indicados y debidamente justificado y aprobados por la jefatura de Consulta Externa.

En el cuadro 10 se presenta un desglose de las tareas mínimas que debe realizar el profesional de psicología contratado en los hospitales periféricos y regionales, para cada una de las actividades sustantivas y complementarias planificadas y ofertadas.

Cuadro 10.

Desglose de tareas mínimas esperadas y modalidades de atención recomendadas para las actividades sustantivas y complementarias realizadas en los hospitales periféricos y regionales.

Actividades sustantivas	Actividades complementarias / apoyo	Tareas mínimas esperadas	Modalidades de atención
Prevención primaria		• Diseño de actividad • Desarrollo de actividad de prevención primaria según temática epidemiológica. • Redacción de reporte de la actividad (incluye evidencias como listas, fotos y otros). • Se puede realizar psicoeducación dentro de la consulta externa con la persona usuaria.	Grupos abiertos no terapéuticos. En la consulta externa (como instrucciones o como parte de la terapia).
Atención Consulta Externa		-Entrevista inicial con la persona usuaria. Firma o lectura de consentimiento. Desarrollo de los objetivos terapéuticos. Realización de las sesiones de intervención, según objetivos terapéuticos. Alta, de acuerdo criterio del profesional y cumplimiento de objetivos terapéuticos. Anotación permanente en el EDUS del usuario.	Individual Grupal terapéutica unidisciplinaria (se debe favorecer esta opción cuando la población tenga las características clínicas que lo permitan y es un criterio del profesional de psicología el que define su apertura. Además se debe favorecer la creación de grupos psicoterapéuticos cuando el servicio tenga listas de espera y cuando el índice de

			concentración[2] lo indique).
Atención intrahospitalaria		Entrevista inicial. Atención terapéutica brindada (intervención breve) Anotación en el EDUS del usuario.	Individuales Grupal psicoterapéutica acorde con las condiciones de salud de las personas hospitalizadas en estancia larga.
Atención en Servicio de Emergencias		Entrevista inicial. Atención terapéutica brindada (intervención breve) Anotación permanente en el EDUS del usuario.	Individual
Procedimiento de evaluación psicológica: aplicación de instrumentos de medición psicológicos para la consulta externa o interconsultas		Agendamiento del procedimiento de evaluación a través de los instrumentos de medición psicológica en el tiempo definido de 60 minutos por procedimiento. Anotación en el EDUS de los resultados Comunicación a la persona usuaria sobre los resultados en espacios la consulta externa, hospitalización y emergencias.	Individual o grupal (según el manual del instrumento de medición).
Sesiones clínicas técnicas		Revisión de casos de personas usuarias en modalidades inter o unidisciplinarias Anotación en EDUS, según el perfil correspondiente.	Grupos profesionales de análisis de información
Comisiones y grupos integrados de trabajo (GIT-equipos), con aval de Autoridades, donde psicología es parte de la plantilla		Lo definido en los documentos de normalización o regulatorios avalados por la Gerencia Médica para este efecto	No aplica

[2] El índice de concentración se refiere a la cantidad de atenciones de personas usuarias subsecuentes en el periodo de un año.

(Violencia, CEINNA; Salud Mental)			
	Actividades técnico-logísticas	Algunos ejemplos, pero no son exhaustivos: llenado de documentos administrativos solicitados por diferentes autoridades institucionales, integración de cuadros estadísticos y la atención de supervisiones disciplinarias, docencia, investigación, ingreso de resultados de pruebas al EDUS, elaboración de materiales para talleres o sesiones psicoterapéuticas, clasificación de referencias entre otras.	No aplica

Fuente: elaboración propia

Nota: las celdas en color verde no contienen información para esa actividad.

Hospitales nacionales, hospitales y centros especializados

Este es el mayor nivel de complejidad, siendo que los hospitales nacionales, así como los hospitales y centros especializados tienen como área de atracción a la Red de la que son cabeza o a todo el país (respectivamente), según su ámbito de competencia, de esta forma se realiza el siguiente desglose del tiempo por actividad sustantiva, modalidades de atención, escenarios de atención y otras variables para aplicar en este nivel.

En el cuadro 11 se describen las prestaciones de servicios en salud psicológicas definidas para estos establecimientos.

Cuadro 11

Descripción de las prestaciones de servicios de salud en los hospitales nacionales, así como hospitales y centros especializados del III Nivel.

Establecimientos	**Actividad**							**Total**
	Atención psicológica[a]						Complementaria / apoyo	
	Prevención primaria	Consulta externa	Interconsulta (hospital y emergencias)	Aplicación, calificación, interpretación de instrumentos de medición psicológicos	Sesiones clínicas técnicas	Comisiones y equipos oficiales		
Hospital nacional	85%						15%	100%
Hospital – centro especializado	85%						15%	100%

Fuente: Elaboración propia

Notas: [a] El continuo del concepto Atención psicológica, permite que el establecimiento de salud programe cada rubro, no obstante, la prioridad deberá ser siempre sin excepción la prestación directa de servicios psicología en la Consulta Externa, hospitalización y emergencias, para el resto de los rubros su programación siempre será inferior a los indicados y debidamente justificado y aprobados por la jefatura de Consulta Externa.

En el cuadro 12 se presenta un desglose de las tareas mínimas que debe realizar el profesional de psicología contratado en los hospitales nacionales, así como los hospitales y centros especializados, para cada una de las actividades sustantivas y complementarias planificadas y ofertadas.

Cuadro 12.

Desglose de tareas mínimas esperadas y modalidades de atención recomendadas para las actividades sustantivas y complementarias realizadas en los hospitales nacionales, así como hospitales y centros especializados del III Nivel.

Actividades sustantivas	Actividades complementarias	Tareas mínimas esperadas	Modalidades de atención
Prevención primaria	No aplica	• Diseño de actividad • Desarrollo de actividad de prevención primaria según temática epidemiológica. • Redacción de reporte de la actividad (incluye evidencias como listas, fotos y otros). • Se puede realizar psicoeducación dentro de la consulta externa con la persona usuaria.	Grupos abiertos no terapéuticos. En la consulta externa (como instrucciones o como parte de la terapia).
Atención Consulta Externa	No aplica	-Entrevista inicial con la persona usuaria. Firma o lectura de consentimiento. Desarrollo de los objetivos terapéuticos. Realización de las sesiones de intervención, según objetivos terapéuticos. Alta, de acuerdo criterio del profesional y cumplimiento de objetivos terapéuticos. Anotación permanente en el EDUS del usuario.	Individual Grupal terapéutica unidisciplinaria (se debe favorecer esta opción cuando la población tenga las características clínicas que lo permitan y es un criterio del profesional de psicología el que define su apertura. Además, se debe favorecer la creación de grupos psicoterapéuticos cuando el servicio tenga listas de espera y cuando el índice de

			concentración[3] lo indique).
Atención intrahospitalaria	No aplica	Entrevista inicial. Atención terapéutica brindada (intervención breve) Anotación en el EDUS del usuario.	Individuales Grupal psicoterapéutica acorde con las condiciones de salud de las personas hospitalizadas en estancia larga.
Atención en Servicio de Emergencias	No aplica	Entrevista inicial. Atención terapéutica brindada (intervención breve) Anotación permanente en el EDUS del usuario.	Individual
Procedimiento de evaluación psicológica: aplicación de instrumentos de medición psicológicos para la consulta externa o interconsultas	No aplica	Agendamiento del procedimiento de evaluación a través de los instrumentos de medición psicológica en el tiempo definido de 60 minutos por procedimiento. Anotación en el EDUS de los resultados Comunicación a la persona usuaria sobre los resultados en espacios la consulta externa, hospitalización y emergencias.	Individual o grupal (según el manual del instrumento de medición).
Sesiones clínicas técnicas	No aplica	Revisión de casos de personas usuarias en modalidades inter o unidisciplinarias Anotación en EDUS, según el perfil correspondiente.	Grupos profesionales de análisis de información
Comisiones y grupos integrados de trabajo (GIT-equipos), con aval de Autoridades, donde psicología es parte de la plantilla		Lo definido en los documentos de normalización o regulatorios avalados por la Gerencia Médica para este efecto	No aplica

[3] El índice de concentración se refiere a la cantidad de atenciones de personas usuarias subsecuentes en el periodo de un año.

(Violencia, CEINNA; Salud Mental)			
	Actividades técnico-**logísticas**	Algunos ejemplos, pero no son exhaustivos: llenado de documentos administrativos solicitados por diferentes autoridades institucionales, integración de cuadros estadísticos y la atención de supervisiones disciplinarias, docencia, investigación, ingreso de resultados de pruebas al EDUS, elaboración de materiales para talleres o sesiones psicoterapéuticas, clasificación de referencias entre otras.	No aplica

Fuente: Elaboración propia

Oferta de Servicios para las personas usuarias

La atención psicológica podrá ser solicitada por el equipo médico en salud tratante, garantizando el acceso a los servicios psicológicos, según el principio de oportunidad y derecho a la salud. Considerando el nivel de complejidad y capacidad resolutiva del establecimiento de salud y por el personal de otras disciplinas que estén incluidas en las ofertas especiales de psicología o programas oficializados por la Gerencia Médica, Presidencia Ejecutiva o leyes y decretos, mediante el sistema referencia institucional vigente, dirigida a los profesionales en psicología del centro de salud donde se realiza la atención de la persona usuaria.

Para el escenario de consulta externa, las solicitudes de atención se realizarán mediante la boleta de referencia, las cuales se verán reflejadas en aplicativo de la plataforma EDUS o en su defecto en el sistema institucional vigente para estos efectos.

Las referencias de solicitud de atención pueden incluir aspectos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del abordaje de componentes cognitivos, emocionales, conductuales asociados a los trastornos contenidos en el capítulo F de CIE 10 o su versión vigente.

Cuando la solicitud de atención se genere en escenarios de hospitalización, emergencias y/o urgencias se utilizará la figura de interconsulta. Todas las atenciones deben estar agendadas en el SIAC (de acuerdo con el *Lineamiento para la definición y creación de tipos de consulta en psicología, en el "Sistema Integrado de Agendas y Citas" (SIAC)*, GM-16837-2020), así como las actividades no atencionales programadas para el profesional de psicología.

Quedan fuera de esta oferta de servicios psicológicos las situaciones ajenas al ámbito de la salud, por ejemplo: peritajes de tipo judicial asociados a conducta de tipo criminológica o propia de la psicología forense, riesgos excluidos, diagnóstico de déficit atencional y adecuaciones curriculares ya que su atención es exclusiva del Ministerio de Educación Pública.

Escenarios y Modalidades de atención:

Los escenarios avalados para la atención psicológica son consulta externa, hospitalización y emergencias. Se debe recordar que la promoción de la salud no es una modalidad de atención, pues se aplica para fortalecimiento de factores de protección de la salud.

Las modalidades de atención avaladas para psicología son: la individual y grupal psicoterapéutica (incluye a familia y pareja). Especialmente, se sugiere la articulación de psicoterapia de tipo grupal como una forma de maximizar las atenciones en los establecimientos de salud, sin embargo, esto dependerá de las características locales, distancia geográfica, adecuación a la modalidad psicoterapéutica grupal (por parte de las personas usuarias) y otras que el profesional de psicología considere pertinente en su análisis.

En relación con el agendamiento de los procedimientos para la aplicación de instrumentos de medición psicológica, debido a los cambios en el EDUS, se podrán agendar en los tiempos definidos por el profesional de psicología. Esto significa lo siguiente:

1. El profesional, de acuerdo con el tipo de instrumento de medición psicológico definido y considerando el tiempo que aproximadamente tarde en aplicarse a una persona usuaria (según la recomendación del manual psicométrico de la prueba o escala), determinará la solicitud de agendamiento en SIAC.

2. El profesional de Psicología le enviara en tiempo y forma la estructura de la agenda a la Jefatura de Consulta Externa, para que posterior a su autorización

se traslade a REDES para la programación en el sistema de agendas y citas (SIAC).

3. Una vez definido lo anterior, se le asigna la cita a la persona usuaria y se realiza la aplicación cuando corresponda.

4. Se recomienda que, para no afectar el desempeño de los usuarios durante la aplicación de los instrumentos de medición psicológicos, el profesional de psicología considere el desgaste cognitivo y emocional que puede conllevar, al usuario, el llenado de varios instrumentos en la misma jornada.

5. Se debe utilizar el cuadro 44 (procedimiento programado), para registrar estos procedimientos y debe consignarse en el Expediente Electrónico (SIES), de la persona usuaria.

Lo anteriormente indicado, deja sin efecto, la sección de pruebas del lineamiento GM-18828-2, sobre Tiempos de Consulta del 2011.

El plan de atención y seguimiento en psicología:

El profesional en psicología tratante debe de considerar las condiciones psicológicas presentes en las personas usuarias en el momento actual, para ello, es necesario e indispensable que se registren en anotaciones SIES o sistema de información vigente los objetivos psicoterapéuticos a tratar en cada sesión o cita que se le programe a la persona usuaria, definiendo un tiempo estimado de inicio y finalización de la atención psicológica por brindar consignándolas en el EDUS respectivo.

Los modelos psicoterapéuticos por implementar con las personas usuarias son los que se contienen en los DNT avalados en la CCSS, los cuales corresponden con las mejores prácticas y son basados en la evidencia vigente. Siguiendo las políticas institucionales de atención pronta y oportuna, estas opciones psicoterapéuticas son de estilo breve con una cantidad máxima promedio de 12 sesiones y un número de sesiones mínimas a establecerse por el tratante según condición, evolución y estabilidad psicológica de las personas usuarias. Cuando sea necesario, se pueden utilizar estrategias de intervención en crisis.

Procedimientos psicológicos:

Cuando el profesional en psicología tratante considere justificado el uso de instrumentos de medición psicológica, podrá realizar procedimientos de evaluación psicológica a través de la aplicación de instrumentos de medición psicológica

siempre y cuando no retrase el proceso de atención a los usuarios. El uso de estos instrumentos debe abarcar la medición de aspectos psicológicos relacionados al proceso diagnóstico en estudio clínico, es decir, **debe estar en estricto apego al motivo de consulta**.

Estos procedimientos deben de acompañarse de actividades de revisión e interpretación, estas actividades no configuran consultas psicológicas ya que no requieren la presencia de las personas usuarias.

Procedimientos para el Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS).

El EIS es una actividad complementaria y no corresponde a las acciones sustantivas de prestaciones de servicios de salud en psicología. No obstante, ya que se encuentra normado a nivel Institucional su aplicación en el nivel local, se deberá realizar este procedimiento de la siguiente manera.

1. Se hará uso de los documentos normativos emitidos por la Dirección de Administración y Gestión del Personal (DAGP), para la aplicación de los instrumentos de medición y la entrevista laboral que corresponde a esta actividad, por parte del personal de psicología acreditado y que tiene dentro del perfil de puesto, dicha función, hasta que esa instancia indique otro proceder.
2. Se coordinará anualmente con Recursos Humanos local, la proyección de casos previo empleo (basado en el histórico oficial de RH), para que cada profesional de psicología asignado al EIS, realice el cálculo de horas requeridas anualmente y la previsión de instrumentos de medición psicológica, para la compra respectiva.
3. Esta actividad al no ser una prestación de servicios psicológicos en salud, no debe contabilizar como producción en la Consulta Externa. Se debe coordinar con la Dirección Médica o General, la gestión para la guardia y custodia del expediente psicológico laboral de la persona oferente, por parte del profesional en psicología.

Registro de atenciones en EDUS:

Los resultados de las estrategias de atención, intervención y de los procedimientos realizados en psicología, se incorporarán al EDUS y formarán parte de la información a consignarse en atención psicológica de las personas usuarias. Los profesionales tratantes procederán a realizar el registro de toda la información que se derive producto de la consulta y atención de las personas usuarias en SIES-EDUS. Estas anotaciones serán consignadas en tiempo real, siguiendo lo

establecido en el Lineamiento contenido estándar para las anotaciones de psicología en expediente único en salud EDUS (CCSS, 2017) o las actualizaciones de dicho documento de regulación.

Sobre el tratamiento psicoterapéutico de elección para las personas usuarias

Se aclara que, este apartado incorpora a todos los grupos etarios y que el plan de atención psicológica busca el restablecimiento de la funcionalidad psicológica, el desarrollo de conductas que favorezcan el afrontamiento adaptativo y el bienestar de la persona usuaria, así como la prevención de posibles recaídas, de manera que, al finalizar el tratamiento la persona usuaria pueda tener una posición activa frente a su condición de salud y prevención de eventuales complicaciones.

Por lo anterior, en los servicios de psicología de los tres niveles de atención de la Caja, utilizarán en la atención psicológica de las personas los modelos psicoterapéuticos que actualmente están avalados en la Institución (así como actualizaciones posteriores a la emisión de este documento).

En las situaciones en las que los profesionales en psicología de la CCSS requieran algún tipo de actualización para la implementación de estos modelos psicoterapéuticos, tienen la opción de coordinar la incorporación de esta necesidad en sus planes anuales operativos, en el componente de capacitación de manera que se incluya y considere estas temáticas a nivel local.

Es claro que, los aportes científicos en el campo de la psicología en el ámbito de la salud y en particular para el abordaje del grupo de diagnósticos (Capítulo F del CIE-10) que abarca este paquete de servicios psicológicos, avanza de manera constante.

En este sentido, es posible que se demuestre la efectividad del procedimiento o técnica, del proceso terapéutico o de la relación terapéutica que no haya sido incluida en los otros documentos de regulación técnica vigentes. Ante esa posibilidad, previo a la utilización de otros modelos psicoterapéuticos no descritos en esos documentos, se recomienda que el profesional de psicología tratante solicite autorización para su uso a la Coordinación Nacional de Psicología adjuntando evidencia sobre la eficacia de resultado, de proceso y de relación terapéutica en la literatura de su rama teórico-práctica, esto significa que el profesional tratante debe garantizar una serie de elementos en su práctica, que demuestren y justifiquen la razón para incluir nuevos modelos o técnicas terapéuticas, como parte de la oferta institucional.

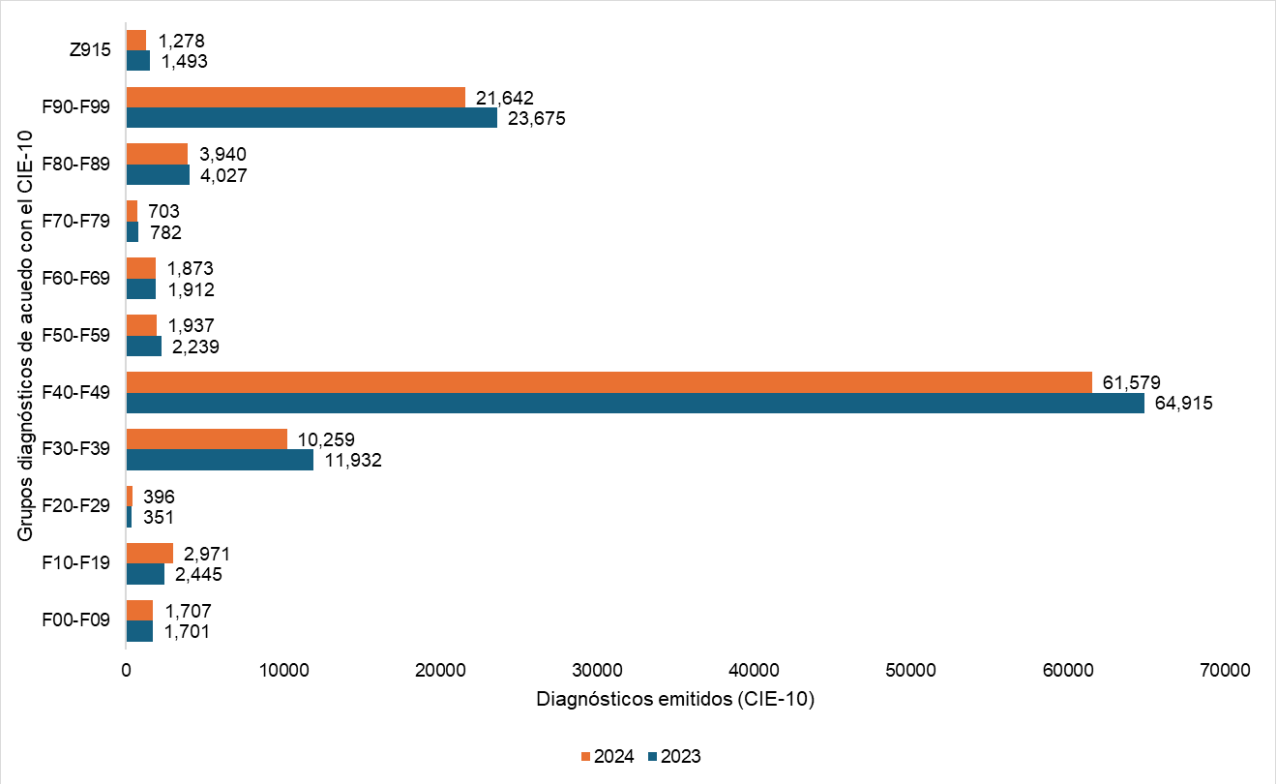
Se debe recordar que al ser la CCSS, un ente autónomo en la prestación de servicios de salud tiene la obligación de velar por el uso de técnicas, tecnologías y aplicaciones en general que beneficien la salud de la persona usuaria (así establecido en la Ley General de Salud, Ley Nacional de Salud Mental y Código de Deontológico y de Ética del CPPCR).

Como se puede observar en las figuras 3, 4 y 5, las personas usuarias que han sido atendidas en los servicios de psicología de la CCSS (de los tres niveles de atención), exhiben una serie de diagnósticos nosológicos en cada agrupación de establecimientos de salud.

La figura 3 permite observar que, en el I Nivel de Atención, las personas usuarias reciben de manera mayoritaria diagnósticos en los grupos (en orden de mayor a menor): F40-F49, F90-F99 y F30-F39. Es importante recordar que es en este nivel donde ingresan las personas a las prestaciones de salud que brinda la CCSS.

Figura 4.

Diagnósticos emitidos los servicios de psicología de consulta externa, por año en los establecimientos de salud del I Nivel de Atención.



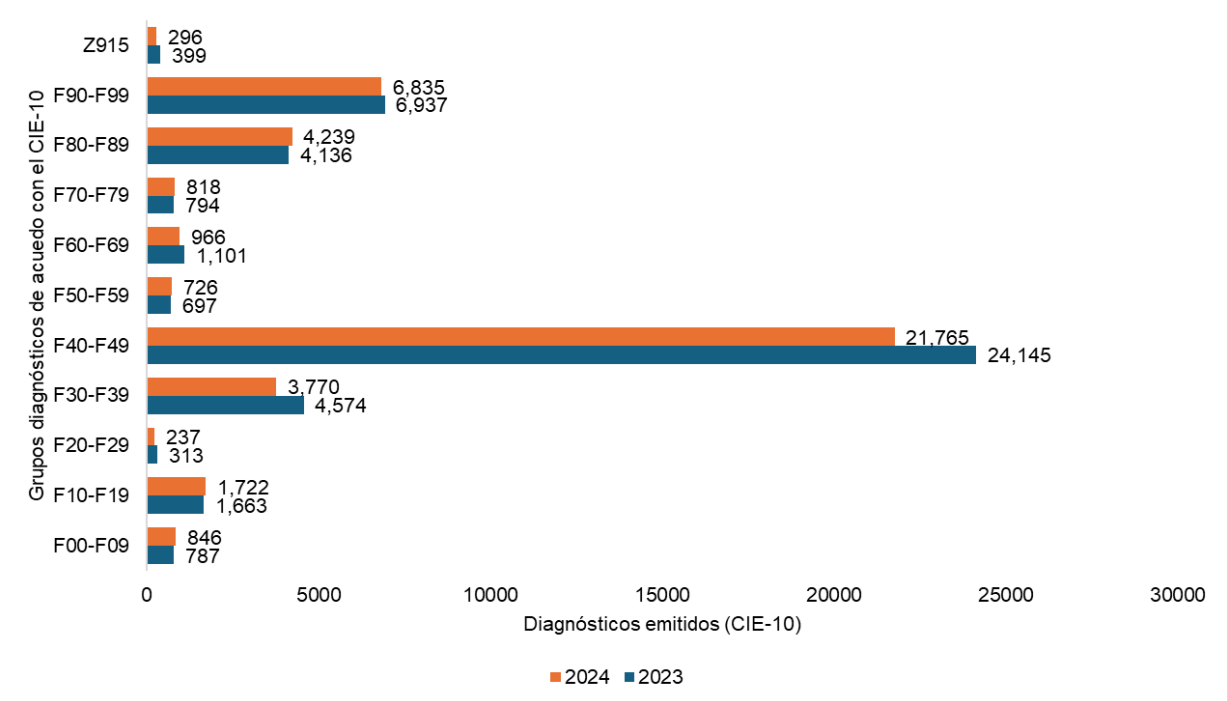
Fuente: Área de Estadísticas de Salud, 2024 (adaptado por la Coordinación Nacional de Psicología, 2025).

La figura 4 contiene la emisión de diagnósticos en personas usuarias que acuden a servicios de Psicología del II Nivel de Atención, principalmente hospitales periféricos y regionales. La proporción de esos diagnósticos es similar a la presentado en la figura 4, de esta forma los principales grupos son (en orden de mayor a menor): F40-F49, F90-F99, F80-F89 y F30-F39.

Destacándose en el caso de los grupos F90-F99 y F80-F89, el cuidado especial en cuanto a que varios de estas atenciones se han encontrado asociadas a aplicación de procedimientos no programados para definir déficit atencional, como apoyo a recursos educativos de otras especialidades médicas o solicitudes de otras Instituciones, situaciones que se oponen a la oferta en salud que genera la CCSS.

Figura 5.

Diagnósticos emitidos los servicios de psicología de consulta externa, por año en los establecimientos de salud del II Nivel de Atención.



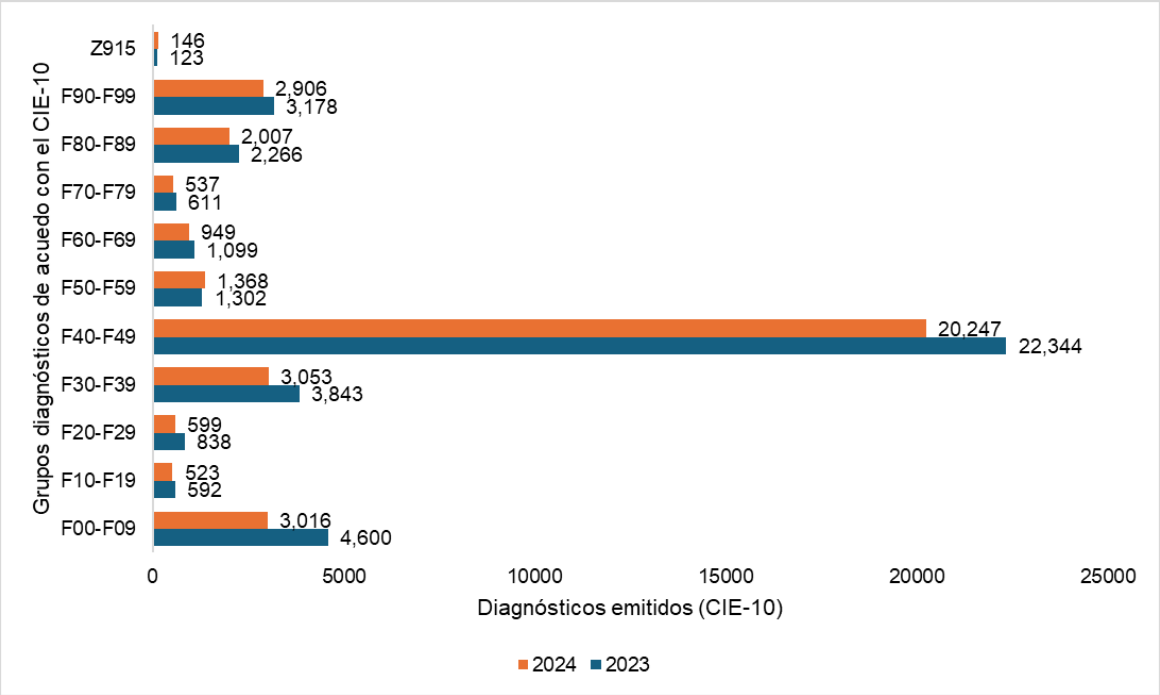
Fuente: Área de Estadísticas de Salud, 2024 (adaptado por la Coordinación Nacional de Psicología, 2025).

La figura 6 presenta una configuración de personas usuarias con diagnósticos, que tiende a asemejarse a la figura 4. En ese sentido, la mayor frecuencia de tipos de diagnósticos es la siguiente (de mayor a menor): F40-F49, F30-F39, F00-F09 y F90-

F99. En este nivel se aprecia una mayor aparición de personas con diagnósticos relacionados con alteraciones del pensamiento (F00-F99).

Figura 6

Diagnósticos emitidos los servicios de psicología de consulta externa, por año en los establecimientos de salud del III Nivel de Atención.

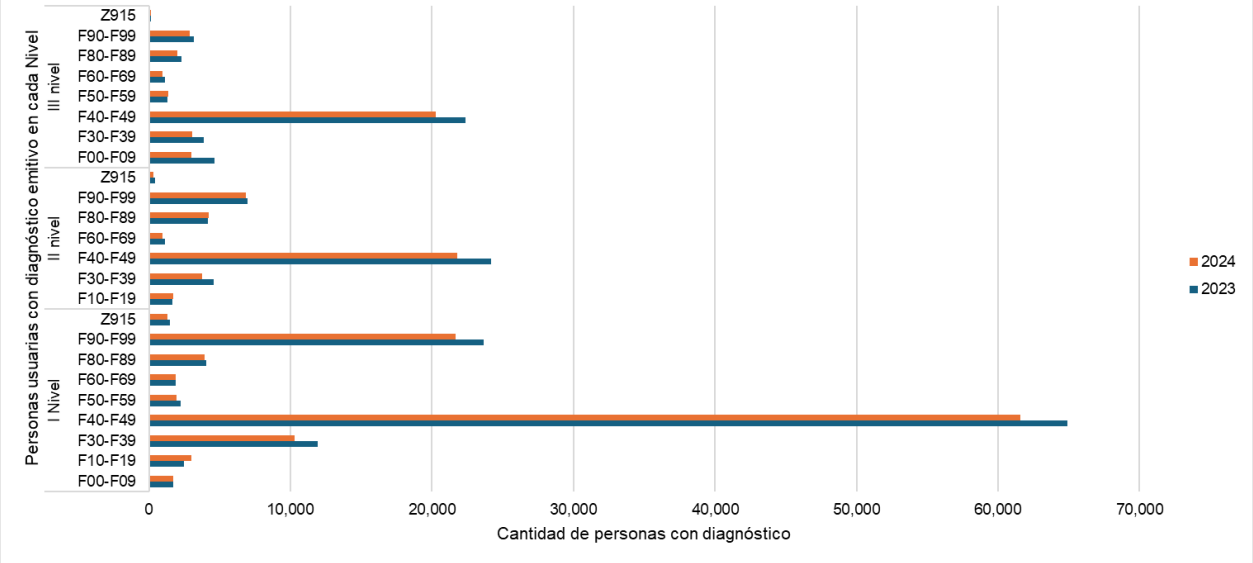


Fuente: Área de Estadísticas de Salud, 2024 (adaptado por la Coordinación Nacional de Psicología, 2025).

La figura 7 expone la comparación entre los diferentes Niveles de Atención, de acuerdo con el año y los diagnósticos con mayores frecuencias de aparición (mayores a 1000 diagnósticos por código). Se puede observar que el grupo F40-F49 es el de más alta emisión en los tres Niveles, seguido del F90-F99 y del F30-F39. Con algunas excepciones se puede notar que el patrón de comportamiento de los diagnósticos por Nivel de Atención tiende a mantener patrones como los indicados en las líneas anteriores.

Figura 7.

Gráfica comparativa de los diagnósticos emitidos en los servicios de psicología de consulta externa, por año en los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.



Fuente: Área de Estadísticas de Salud, 2024 (adaptado por la Coordinación Nacional de Psicología, 2025).

Tomando como base lo expuesto en las figuras, 3, 4, 5 y 6, se pueden notar que existen algunos grupos de personas con diagnósticos nosológicos como los: F30-F39, F40-F49, F60-F69 y F90-F99 que se manifiestan en los tres niveles de atención. Esto es coherente con lo que la literatura especializada (Dalgleish, Black, Johnston & Bevan, 2020), apunta sobre la presencia transversal, en diferentes trastornos psicológicos, de una serie de características comunes como son: la disregulación emocional, los patrones cognitivos negativos y las conductas de evitación (Etchmendy, Rasal y Fernández-Álvarez, 2024; Mirapeix, 2017).

Lo anterior es fundamental en los procesos de atención de psicología de la CCSS, ya que, al existir coincidencia en los tipos de diagnósticos atendidos en los tres niveles, aparte de la nosología, se deben generar análisis clínicos de cada caso y, en ese sentido, la presencia de aquellos grupos de indicadores que permitirían a los profesionales la comparativa sobre el estado de severidad de cada persona, en relación con esos tres aspectos comunes.

Partiendo de esa base epidemiológica y considerando que uno de los principios de un sistema de salud pública, que, para efectos de Costa Rica está representado por las prestaciones de salud que brinda la CCSS, se puede observar que las diferencias en los tipos de atención según las acciones atencionales en los tres niveles de atención, no están exhibiendo, per se, una diferenciación según: el modelo de atención en salud vigente, así como el tipo de establecimiento de salud (complejidad), el motivo de consulta y las interacciones clínicas del estado psicológico de la persona usuaria, así como el agravamiento de los síntomas psicológicas que exhibe la persona usuaria.

Por esto, con el fin de complementar lo regulado en el "Lineamiento referencias y contrarreferencias a servicios de psicología en los tres niveles de atención. Código L.GM.DDSS.ARSDT.31072024" avalado en nota GM-12220-2024, se incluye en este apartado una serie de regulaciones concernientes a los criterios para referir personas usuarias de un establecimiento de salud de menor complejidad a uno de mayor complejidad, así como las estrategias para las emisiones de contrarreferencias, emisión de altas y otros aspectos relacionados. Se advierte que, esta sección se debe analizar, siempre, a la luz del antecitado lineamiento o sus actualizaciones posteriores.

Mecanismos de referencia en los servicios de Psicología de la CCSS

En esta sección se describen las estrategias que deben seguir los servicios de psicología para referir personas usuarias (en la Consulta Externa), a lo largo de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, de acuerdo con las características de su cuadro clínico.

Áreas de Salud tipo I, II y III

Se incluyen este apartado a las Áreas de Salud Tipo I, II y III. Estos establecimientos de salud abarcan las funciones de la captación, el tamizaje, la intervención temprana, la resolución inicial de las alteraciones psicológicas de carácter leves a moderadas, así como la atención de referencia directa desde medicina general u otras especialidades médicas, presentes en las Áreas de Salud tipo II y III (principalmente).

Se aplicarán los consentimientos informados oficialmente avalados y vigentes en la Institución, ya sea en modalidad presencial o virtual.

Mecanismos de valoración y atención Inicial

- **Referencia y agendamiento**: las personas usuarias serán referidas a psicología por medicina de los EBAIS de las Áreas de Salud tipo I, en el caso de las Áreas de Salud tipo II y III, las referencias pueden ingresar por medicina general, especialidades en medicina o psicología directamente.

- Psicología del establecimiento de salud puede generar un sistema de valoración de referencias, una vez hecho esto, se debe coordinar el agendamiento vía REDES.

- Una vez logrado lo anterior, REDES agendará a cupo (o prioridad según el criterio de filtro de psicología), en la agenda disponible del profesional de psicología con cupo nuevo más cercano.

- En el caso de cupos subsecuentes (control) en la Consulta Externa, se agendará con el profesional de psicología tratante (esto salvo casos de excepción como vacaciones, incapacidades, entre otras), pero se debe velar por que la persona usuaria no quede sin abordaje, por situaciones que pueden ser prevenidas en la organización del servicio y según la gestión de la jefatura de Consulta Externa.

- Se pueden recibir contrarreferencias desde establecimientos de mayor complejidad (hospitales periféricos, regionales, nacionales y especializados), cuando la condición de salud psicológica de la persona usuaria haya sido estabilizada por los profesionales de psicología (esto implica que el caso queda de alta y se recomienda seguimiento local) y, además no correspondan a programas especiales que requieran continuidad y atención en los ámbitos hospitalarios.

- Se aplicarán los consentimientos informados oficialmente avalados y vigentes en la Institución, ya sea en modalidad presencial o virtual.

- **Valoración inicial**: el profesional de psicología realizará una valoración de las personas usuarias con cupo nuevo (en Consulta Externa), para lo que empleará la entrevista clínica.

- **Intervenciones psicológicas**: de acuerdo con el cuadro clínico que presenta la persona en la Consulta Externa, se podrán desarrollar procesos de atención psicológica, se brindan algunos ejemplos y recomendaciones:

    - Educación y psicoeducación en salud psicológica.

    - Técnicas de manejo de estrés y regulación emocional, como objetivo primordial, pero se pueden ampliar según el cuadro clínico de la persona usuaria.

    - Intervenciones psicoterapéuticas breves, basadas en evidencia y focalizadas, por ejemplo, técnicas de relajación, intervenciones motivacionales, entre otras y que sean consistentes con los documentos de regulación técnica en psicología avalados y vigentes.

Se recomienda que las sesiones de cupo control no excedan las 12 sesiones.

- Se podrán aplicar modalidades de terapia grupal, en los casos de personas que, por su condición de salud psicológica, sean candidatas para este recurso psicológico. La creación de estos grupos psicoterapéuticos será criterio exclusivo del profesional de psicología, no obstante, se recomienda que sea un formato de elección cuando existan listas de espera o tiempos distantes entre las citas de seguimiento de los usuarios.

- Con el fin de fortalecer los criterios técnicos sobre casos de difícil resolución, se podrán desarrollar sesiones técnicas uni o interdisciplinarias para el análisis de casos según sus características.

- Tanto para las personas usuarias primera vez o en citas de control (subsecuentes), se podrán aplicar los instrumentos de medición psicológicos adquiridos, que sean parte del Catálogo Institucional de Bienes y Servicios, quedando a criterio del profesional de psicología, la decisión de su aplicación, así como el tipo de instrumento para implementar (se recuerda que los instrumentos se agendan como procedimientos, no como Consulta Externa).

- **Procedimientos de psicología**. Todos los procedimientos que se apliquen en psicología (por ejemplo, los instrumentos de medición psicológicos), deben ser agendados en SIAC, documentos en el cuadro 44 y se debe incluir la información resultante en el SIES de la persona usuaria. Los procedimientos de psicología oficiales de la Institución son los que tiene registrados el Área de Estadísticas de Salud, y a nivel local REDES, en los cuadros 44 y el EDUS, y son producto del catálogo oficial CIE-9-MC, Clasificación de Procedimientos (eCIEMaps v4.1.00, 2025)) para procedimientos en salud internacionales de la OMS.

- **Emisión de diagnóstico nosológico y reporte en SIES**: los profesionales de psicología de los establecimientos de salud indicados en este apartado valorarán y darán atención inicial a las personas usuarias referidas. Una vez realizada la consulta se indicará el código diagnóstico correspondiente en el SIES de la persona usuaria (de acuerdo con el CIE-10).

  Cuando una persona usuaria, que sea atendida en psicología, exhiba síntomas exacerbados y que afecten la funcionalidad de su comportamiento en el corto plazo, los cuales no pueden ser abordados con las condiciones

del establecimiento de salud (por ejemplo: un episodio de psicosis aguda, trastornos del neurodesarrollo con comorbilidades que comprometen su integridad y salud, entre otros de estas calidades), **deberán ser referidos a un establecimiento de mayor complejidad**. Las referencias siempre deberán indicar las acciones técnicas realizadas para abordar el caso y la situación que amerita su referencia. Esto sin descontar los datos adicionales que la boleta o sistema electrónico de referencia tenga estipulados a nivel institucional.

También se podrán atender personas que, según el análisis de caso y motivo de consulta, presenten cuadros como la conducta o la ideación suicidas que, por su condición, puedan ser atendidos en la consulta externa (**cuando se presenten casos que implican un riesgo para la vida de la persona usuaria, plan estructurado de conducta suicida o intento de autoeliminación en curso, deben ser remitidos a los servicios de Urgencias para lo correspondiente**).

Se recuerda que existen restricciones en la atención de ciertos diagnósticos nosológicos, reportadas en secciones precedentes (que no son parte de la oferta de prestaciones de salud de la CCSS en psicología), sin embargo, toda persona debe ser atendida la primera vez y, según el criterio del profesional de psicología, se realizará la intervención en salud que corresponda o se emitirá el alta correspondiente.

Adicionalmente, los profesionales de psicología llenaran todas las secciones correspondientes en el SIES de la persona usuaria, recordando que este es el único registro oficial de la información de los usuarios.

Se recuerda que los diagnósticos de emisión como causa principal son los contenidos en el Capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento, Sección F del CIE-10[4] (o su versión actualizada y oficializada en la CCSS) y los correspondientes a conducta suicida como el Z915 y R458.

- **Emisión de alta**. De acuerdo con la nota GM-AES-1-1718-2024, el profesional en psicología tratante, definirá de manera expresa en el SIES de la persona usuaria, la condición de alta. Esto cuando la persona usuaria haya tenido una mejora significativa en su funcionalidad psicológica, en relación con el motivo de consulta por el que pidió cita con psicología.

[4] Para el caso de programas especializados, programas institucionales u ofertas especiales, con aval gerencial, cuando establezcan diagnósticos nosológicos pertinentes a psicología, se usarán en esos casos los indicados en los documentos de regulación técnica. .

Si la persona usuaria debe ser referida al siguiente tipo de establecimiento de salud de siguiente complejidad, de la Red de Atención, se emite la referencia y se establece de manera explícita el alta en el SIES del usuario.

Criterios para referir una persona usuaria a los hospitales periféricos o regionales

Los profesionales de psicología de las Áreas de Salud tipo I, II y III, podrán remitir referencias a sus colegas de los establecimientos de salud del siguiente nivel de complejidad (hospitales periféricos y regionales), considerando los siguientes criterios básicos, durante la valoración y atención de la persona se podrán considerar otros partiendo del criterio clínico del profesional de psicología tratante.

- **Síntomas persistentes:**
  No se observa cambio o mejoría (incluso se detecta incremento de la sintomatología problema), en la condición psicológica de las personas, luego de seis sesiones, si, tras un período de intervención (por ejemplo, 4 a 6 sesiones), los síntomas persisten o se agravan.

- **Aumento o agravamiento de las características clínicas del caso:**
  La presencia de comorbilidades significativas (síntomas de depresión psicótica, por ejemplo), deterioro en la funcionalidad social, laboral o familiar (por ejemplo, disminución clara y estable en la interacción con personas significativas, por más de un mes) o la presencia y aumento de conductas de riesgo (autolesiones, entre otros) que requieran una intervención de mayor especialización y abordaje interdisciplinario, no podrían dar una resolución a los problemas de salud psicológica de la persona usuaria y se requiere la intervención de un establecimiento de salud con mayor complejidad.

- **La persona usuaria no demuestra una mejoría como respuesta al tratamiento inicial.**
  Cuando las estrategias descritas en el punto anterior no logran reducir la sintomatología, se podría estar ante una toma de decisión técnica para ampliar las estrategias de abordaje y la evaluación del caso, en su defecto se podrá solicitar un abordaje clínico de mayor especialización en el siguiente nivel de atención. Previo a una referencia, se puede desarrollar una sesión técnica clínica uni o interdisciplinaria, para analizar el caso.

En todos los casos, ya sea que la persona usuaria se mantenga en atención en las Áreas de Salud tipo I, II y III o se refieran al siguiente establecimiento de salud en complejidad ascendente, se deberán realizar las anotaciones en el perfil del EDUS

permitido para estas actividades, dando de alta en el momento que se realiza la referencia.

En complemento, tal y como está estipulado en otras regulaciones técnicas de la disciplina, las referencias se consignarán obligatoriamente en los aplicativos EDUS o en la hoja de referencias (GM-2123-2025, Formulario “Gestión de pacientes”), según corresponda.

Se recomienda que, al realizar las referencias de un nivel de menor complejidad a otro de mayor complejidad, se procure establecer una sesión técnica de análisis de los casos referidos para que los profesionales de psicología de ambos establecimientos puedan tener los elementos técnicos necesarios para el abordaje, transición y continuidad de la atención.

Hospitales periféricos y regionales

Estos establecimientos de salud son aquellos que exhiben una capacidad técnica, de equipamiento, infraestructura y oferta de servicios interdisciplinarios, para personas con síntomas psicológicos de moderada a alta dificultad en su abordaje o que no demuestran avance o mejoría en su condición de salud psicológica.

Estrategia de filtrado, valoración y atención psicoterapéutica

- **Referencia y agendamiento**: Los profesionales de psicología de estos hospitales pueden recibir referencias de las áreas de salud tipo I, II y III. También se podrán recibir referencias de medicina (general o especializada) del mismo hospital, de programas especiales (avalados por la Gerencia Médica).

  De igual manera, se podrán captar contrarreferencias emitidas por los hospitales nacionales u hospitales-centros especializados del Tercer Nivel de Atención, cuando la condición de salud psicológica de la persona usuaria lo requiera.

  Se exceptúan de este caso, las contrarreferencias asociadas a programas especializados del III Nivel, que requieren mantener a la persona usuaria en esos establecimientos de salud de máxima complejidad.

  Se aplicarán los consentimientos informados oficialmente avalados y vigentes en la Institución, ya sea en modalidad presencial o virtual.

Los profesionales de psicología podrán establecer criterios de referencias que permitan educar a la Red local de psicología, sobre los casos por atender en estos establecimientos de salud.

- **Valoración psicológica**: el profesional de psicología realiza una valoración exhaustiva de cada caso recibido por referencia o contrarreferencia, esto mediante el desarrollo de entrevistas clínicas.

  En el caso de cupos subsecuentes (control), el profesional de psicología, de igual manera podrá aplicar instrumentos de medición cuando lo considere conveniente. Para ello se deben agendar en SIAC como procedimientos programados (recordar que no se agendan como Consulta Externa).

- **Intervenciones psicológicas:** de acuerdo con el cuadro clínico evidenciado en la referencia o contrarreferencia de la persona usuaria, así como la valoración inicial del profesional de psicología se podrán realizar al menos las siguientes acciones:

  - Aplicación de intervenciones psicoterapéuticas, basadas en los documentos de regulación técnicos avalados y vigentes, de tipo intervención breve, focalizadas en el motivo de consulta o referencia y adaptadas a las características sintomáticas de la persona usuaria. Se recomienda que las sesiones de control, no excedan las 12 citas.

  - Implementación de las diferentes modalidades de intervención avaladas en psicología, de manera especial, para el caso de la aplicación de la psicoterapia grupal, esta se realizará en los casos de personas que, por su condición de salud psicológica, sean candidatas para este recurso.

  - La creación de los grupos psicoterapéuticos será criterio exclusivo del profesional de psicología, no obstante, se recomienda que sea un formato de elección cuando existan listas de espera o tiempos distantes entre las citas de seguimiento de los usuarios.

  - Aplicación de instrumentos de medición psicológicos, incluidos en el Catálogo Institucional de Bienes y Servicios de la Gerencia Logística.

  - Con el fin de fortalecer los criterios técnicos sobre casos de difícil resolución, se podrán desarrollar sesiones técnicas uni o interdisciplinarias para el análisis de casos según sus características.

- **Procedimientos de psicología**. Todos los procedimientos que se apliquen en psicología (por ejemplo, los instrumentos de medición psicológicos), deben ser agendados en SIAC, documentos en el cuadro 44 y se debe incluir la información resultante en el SIES de la persona usuaria. Los procedimientos de psicología oficiales de la Institución son los que tiene registrados el Área de Estadísticas de Salud, y a nivel local REDES, en los cuadros 44 y el EDUS, y son producto del catálogo oficial CIE-9-MC, Clasificación de Procedimientos (eCIEMaps v4.1.00, 2025)) para procedimientos en salud internacionales de la OMS.

- **Emisión de diagnóstico nosológico y reporte en EDUS-SIES**: los profesionales de psicología de los hospitales periféricos y regionales, valorarán y darán atención a las personas usuarias referidas por medicina o psicología (de su mismo establecimiento, del I Nivel o del III Nivel). Se atenderán todos los diagnósticos nosológicos remitidos en el Formulario "Gestión del Paciente" o mediante el aplicativo del SIES.

  Se emitirán los diagnósticos nosológicos correspondientes en el SIES (de acuerdo con el CIE-10), tanto para fines de tipificación del caso, como de registro epidemiológico.

  En este tipo de establecimientos se priorizará la atención y resolución de los casos atendidos, haciendo uso de la expertise clínica (evaluación, tratamiento y rehabilitación) del profesional de psicología. Se recuerda que los diagnósticos de emisión como causa principal son los contenidos en el Capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento, Sección F del CIE-10 (o su versión actualizada y oficializada en la CCSS) y los correspondientes a conducta suicida como el Z915 y R458.

  Debido a que los hospitales periféricos y regionales, presentan un grado de complejidad media y alta, pueden atender casos de mayor gravedad o con síntomas exacerbados como, por ejemplo: psicosis, alteraciones del pensamiento asociados a demencias y equivalentes, problemas del neurodesarrollo y, en general todas aquellas alteraciones mentales y del comportamiento, que por la magnitud de los hospitales, pueden recibir, no solo la atención psicológica especializada, sino la intervención de otras especialidades médicas y no médicas, no presentes en las Áreas de Salud tipo I, II y III.

  También se podrán atender personas con diagnósticos relacionados con conducta o ideación suicidas que, por su condición, puedan ser atendidos en la consulta externa (cuando se presenten casos que implican un riesgo para

la vida de la persona usuaria, plan estructurado de conducta suicida o intento de autoeliminación en curso, deben ser remitidos a los servicios de Emergencias para lo correspondiente).

Se recuerda que existen restricciones en la atención de ciertos diagnósticos nosológicos, reportadas en secciones precedentes (que no son parte de la oferta de prestaciones de salud de la CCSS en psicología), sin embargo, toda persona debe ser atendida la primera vez, y según el criterio del profesional de psicología, se realizará la intervención en salud que corresponda.

Adicionalmente, los profesionales de psicología llenaran todas las secciones correspondientes en el expediente electrónico (SIES) de la persona usuaria, recordando que este es el único registro oficial de la información en el ámbito de consulta externa e interconsulta.

Emisión de alta. De acuerdo con la nota GM-AES-1-1718-2024, es el profesional en psicología tratante, quien definirá de manera expresa en el SIES de la persona usuaria, la condición de alta. Esto cuando la persona usuaria haya tenido una mejora significativa en su funcionalidad psicológica, en el **motivo de consulta por el que pidió cita con psicología**.

Si la persona usuaria debe ser referida al siguiente tipo de establecimiento de salud de mayor complejidad, de la Red de Atención, se emite la referencia y se establece de manera explícita el alta en el SIES.

Criterios para derivación al Tercer Nivel

- **No respuesta a las intervenciones psicoterapéuticas:** la persona usuaria, tras las citas recomendadas y la aplicación de las técnicas psicoterapéuticas incluidas en las regulaciones avaladas para la disciplina, no muestra cambios conductuales o una mejoría clínica significativa.

- **Presencia o aparición de síntomas de alta severidad:** si, a pesar del tratamiento desarrollado con la persona usuaria, la coordinación con otras disciplinas médicas y no médicas, se observa la presencia sostenida o la aparición de manifestaciones clínicas que incluyen trastornos psicológicos complejos (por ejemplo esquizofrenia, deterioro cognitivo, demencias que requieren una atención altamente especializada) y, que superan la capacidad de intervención de estos establecimientos, se deberá referir al III Nivel.

- **Comorbilidad de trastornos mentales y comportamiento de mayor gravedad:** ante la presencia de personas usuarias con comorbilidades psiquiátricas severas o condiciones que requieren atención multidisciplinaria especializada y, que el hospital periférico o regional, con la actual dotación de personal, equipamiento o infraestructura no puede atender, por lo que la salud de la persona, como principio fundamental, requiere de un apoyo de mayor especialización, deberá ser referida al III Nivel (esto siempre y cuando no sea una condición vida o muerte, en cuyo caso debe ser derivada a los Servicios de Emergencias locales).

En todos los casos, ya sea que la persona usuaria se mantenga en atención en los hospitales periféricos o regionales o se refieran al siguiente establecimiento de salud en complejidad ascendente, se deberán realizar las anotaciones en el perfil del EDUS permitido para estas actividades, dando de alta en el momento que se realiza la referencia.

Se recomienda que, al realizar las referencias de un nivel de menor complejidad a otro de mayor complejidad, se procure establecer una sesión de análisis de los casos referidos para que los profesionales de psicología de ambos establecimientos puedan tener los elementos técnicos necesarios para el abordaje, transición y continuidad de la atención.

En complemento, tal y como está estipulado en otras regulaciones técnicas de la disciplina, las referencias se consignarán obligatoriamente en los aplicativos EDUS o en la hoja de referencias (GM-2123-2025, Formulario “Gestión de pacientes”), según corresponda.

Tercer Nivel de Atención

Los hospitales nacionales, así como los hospitales y centros especializados, representan la mayor capacidad de resolución clínica, cuentan con equipos interdisciplinarios completos, lo que posibilita la atención de las psicopatologías más graves.

Estrategias de atención de mayor especialización

- **Referencia y agendamiento**: Los profesionales de psicología de estos hospitales nacionales, solo recibirán referencias de los hospitales regionales o de aquellas áreas de salud tipo II o III, cuando no tengan un hospital periférico o regional en su Red.
  Los hospitales y centros especializados podrán recibir referencias desde los hospitales nacionales o programas especiales que permitan transferir

usuarios, de acuerdo con regulaciones avaladas institucionalmente. No se remitirán referencias directas desde las áreas de salud tipo I, II o III, así como de los hospitales periféricos o regionales al Tercer Nivel especializado, con el fin de no afectar las atenciones de mayor gravedad en ese nivel.

El Tercer Nivel con hospitales generales, hospitales y centros especializados, podrá recibir referencias de medicina (general o especializada) del mismo hospital o de programas especiales (avalados por la Gerencia Médica), así como referencias tal y como se indicó previamente.

Este grupo de hospitales podrá emitir contrarreferencias, a sus niveles inferiores cuando se determine que la persona usuaria puede ser dada de alta y continuar seguimiento en el nivel local. Se exceptúan de este caso, las contrarreferencias asociadas a programas especializados del III Nivel, que requieren mantener a la persona usuaria en estos establecimientos de salud de máxima complejidad.

Se aplicarán los consentimientos informados oficialmente avalados y vigentes en la Institución, ya sea en modalidad presencial o virtual.

- **Valoración psicológica**: el profesional de psicología de este nivel, desde el ámbito de salud y clínico, en el cual está contratado, realiza una valoración exhaustiva de la persona usuaria que le ha sido referida a su consulta externa.

  Como parte de la valoración de mayor especialización, se puede analizar los casos de mayor gravedad en sesiones técnicas interdisciplinarias o unidisciplinarias.

- **Procedimientos de psicología**. Todos los procedimientos que se apliquen en psicología (por ejemplo, los instrumentos de medición psicológicos), deben ser agendados en SIAC, documentos en el cuadro 44 y se debe incluir la información resultante en el SIES de la persona usuaria. Los procedimientos de psicología oficiales de la Institución son los que tiene registrados el Área de Estadísticas de Salud, y a nivel local REDES, en los cuadros 44 y el EDUS, y son producto del catálogo oficial CIE-9-MC, Clasificación de Procedimientos (eCIEMaps v4.1.00, 2025)) para procedimientos en salud internacionales de la OMS.

- **Intervenciones psicológicas:** debido al tipo de sintomatología de mayor gravedad y la comorbilidad con la que cursan muchas de las personas usuarias referidas a psicología del III Nivel, se requiere la aplicación de procedimientos basados en evidencia y de tipo breve, para dar continuidad a

las atenciones de las personas usuarias que provienen de diferentes fuentes de referencia. Por ello se recomienda que al menos se aplique lo siguiente:

- Terapias psicológicas basadas en evidencia, avaladas en los documentos regulatorios vigentes en la CCSS.

- Las citas no deben de exceder las doce sesiones.

- Implementación de las diferentes modalidades de intervención avaladas en psicología, de manera especial, para el caso de la aplicación de la psicoterapia grupal, esta se realizará en los casos de personas que, por su condición de salud psicológica, sean candidatas para este recurso psicológico.

- La creación de estos grupos psicoterapéuticos será criterio exclusivo del profesional de psicología, no obstante, se recomienda que sea un formato de elección cuando existan listas de espera o tiempos distantes entre las citas de seguimiento de los usuarios.

- Aplicación de instrumentos de medición psicológicos, incluidos en el Catálogo Institucional de Bienes y Servicios de la Gerencia Logística.

- Programas de rehabilitación psicológica clínica, seguimiento de casos y coordinación con equipos multidisciplinarios, cuando el caso sea parte de ofertas o programas especializados, institucionalmente avalados por la Gerencia Médica.

- Programas de rehabilitación intensiva y seguimiento estrecho, con coordinación de equipos multidisciplinarios.

- Por las características del III Nivel, se recomienda que las personas usuarias que exhiben indicadores de los siguientes grupos diagnósticos, que han sido atendidas en el I o II Nivel, sean primero valoradas y atendidas allí y, posterior al análisis clínico del caso, si es necesario, que se les refiera por medio de la Red de Servicios de Salud al III Nivel. Se detallan los diagnósticos prioritarios de atención en el III Nivel:

    - Trastornos neurocognitivos (F00-F09) en fases avanzadas.
    - Trastornos por uso de sustancias con dependencia severa (F10-F19).
    - Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (F20-F29).

- Trastornos afectivos graves (F30-F39) incluyendo Trastorno Bipolar y Depresión Mayor con riesgo suicida.
- Trastornos graves de ansiedad (F40-F41) con descompensación.
- Trastornos de la personalidad graves (F60-F69) con riesgo para sí o terceros.
- Trastornos alimentarios con riesgo vital (F50).
- Conductas suicidas agudas (Z91.5, X60-X84), que a pesar de los abordajes realizados en la consulta externa de psicología del I y II Nivel, no han tenido respuesta terapéutica positiva (mejoría de los síntomas asociados).
- Personas con diagnósticos asociados a programas especializados.
- Las personas con los diagnósticos indicados en las viñetas anteriores son de atención prioritaria en los hospitales del tercer nivel y, mientras no se les haya dado de alta en el III Nivel, no deben ser transferidos al I o II Nivel.

- **Emisión de diagnóstico nosológico y reporte en SIES**: los profesionales de psicología de los hospitales del III Nivel, valorarán y darán atención a las personas usuarias referidas por medicina o psicología (de su mismo establecimiento o de los hospitales regionales). Se atenderán todos los diagnósticos nosológicos remitidos en el Formulario “Gestión del Paciente” o mediante el aplicativo del SIES (con especial énfasis los indicados en el apartado precedente).

  Se emitirán los diagnósticos nosológicos correspondientes en el SIES (de acuerdo con el CIE-10), tanto para fines de tipificación del caso, como de registro epidemiológico.

  Se recuerda que los diagnósticos de emisión como causa principal son los contenidos en el Capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento, Sección F del CIE-10 (o su versión actualizada y oficializada en la CCSS) y los correspondientes a conducta suicida como el Z915 y R458.

  Debido a que los hospitales del III Nivel, presentan el máximo nivel de especialización y complejidad, pueden atender todos casos de mayor gravedad o con síntomas exacerbados, en los diferentes grupos poblacionales.

  Se recuerda que existen restricciones en la atención de ciertos diagnósticos nosológicos, reportadas en secciones precedentes (que no son parte de la oferta de prestaciones de salud de la CCSS en psicología), sin embargo, toda

persona debe ser atendida la primera vez, y según el criterio del profesional de psicología, se realizará la intervención en salud que corresponda.

Adicionalmente, los profesionales de psicología, llenaran todas las secciones correspondientes en el SIES, recordando que este es el único registro oficial de la información de la persona usuaria.

Emisión de alta. De acuerdo con la nota GM-AES-1-1718-2024, es el profesional en psicología tratante, quien definirá de manera expresa en el SIES de la persona usuaria, la condición de alta. Esto cuando la persona usuaria haya tenido una mejora significativa en su funcionalidad psicológica, en el motivo de consulta por el que pidió cita con psicología.

Si la persona usuaria debe ser contrarrreferida al siguiente tipo de establecimiento de salud de la Red de Atención, se emite el documento y se establece de manera explícita el alta en el SIES.

Mecanismos de Contrarreferencia

Con el fin de optimizar la emisión de contrarreferencias desde un establecimiento de salud, de mayor complejidad a otro de menor complejidad, se establecen las pautas generales para su implementación en los servicios de Psicología de la CCSS.

A. Hospitales nacionales y hospitales-centros especializados hacia hospitales periféricos y regionales

- Estabilización de la sintomatología aguda de la persona usuaria (se encuentra estable y puede continuar atención en el ámbito regional).
- El riesgo psicológico (afectación en las funciones de la vida cotidiana, así como la integridad de la persona), ha disminuido y a juicio del psicólogo tratante, puede continuar atención en el ámbito regional.
- Cercanía con el lugar de arraigo, continuidad del plan de tratamiento en los establecimientos de salud de tipo hospital regional o periférico.
- Las contrarreferencias deben ser claras en el documento de “Gestión de Pacientes” o en el aplicativo del SIES, se debe documentar el motivo de remisión del usuario, el plan de tratamiento, la actual

sintomatología y, debe coordinarse con el establecimiento de salud para la adecuada continuidad de la atención de la persona usuaria.

Se podrá referir directamente al I Nivel de Atención, cuando exista una remisión completa de los síntomas, exista una red de apoyo para la persona usuaria y se recomiende seguimiento regular al usuario para mantener estable su condición psicológica.

Se recomienda que, al realizar las contrarreferencias de un nivel de mayor complejidad a otro de menor complejidad, se procure establecer una sesión de análisis de los casos referidos para que los profesionales de psicología de ambos establecimientos puedan tener los elementos técnicos necesarios para el abordaje, transición y continuidad de la atención.

B. Contrarreferencias desde los Hospitales Periféricos y Regionales a las Áreas de Salud tipo I, II y III

- Se presenta una mejoría significativa, así como estabilización de los síntomas asociados al motivo de consulta.
- La persona usuaria ha demostrado que adquirió la capacidad para desenvolverse de manera autónoma con seguimiento esporádico.
- Se desarrolla un plan de alta, donde se educa a la persona usuaria en pautas de autocuidado, se da de alta y se remite a las Áreas de Salud tipo I, II o III, donde se dará continuidad a la atención preventiva y para evitar recaídas.
- Se recomienda que, al realizar las contrarreferencias de un nivel de mayor complejidad a otro de menor complejidad, se procure establecer una sesión de análisis de los casos referidos para que los profesionales de psicología de ambos establecimientos puedan tener los elementos técnicos necesarios para el abordaje, transición y continuidad de la atención.

Criterios de alta en cada nivel

Se detallan algunas recomendaciones para considerar la emisión de altas en psicología, sin embargo, no agotan otros criterios técnicos que decida el profesional en psicología tratante del caso.

A. Alta en las Áreas de Salud tipo I, II y III

- Disminución significativa de síntomas detectados como consecuencia del tratamiento.
- Recuperación de la capacidad funcional de la persona usuaria.
- Ausencia de signos de riesgo inminente en la salud integral, en la vida de otros y los bienes de terceros.
- Lo anterior se debe documentar en el SIES y se debe indicar de forma expresa el alta.

B. Alta en el segundo nivel (Hospitales periféricos y regionales).

- Estabilización y reducción de la sintomatología.
- Cumplimiento de los objetivos terapéuticos planteados durante el tratamiento del usuario.
- La persona usuaria demuestra que puede gestionar de manera autónoma el manejo de su enfermedad, con apoyo en el nivel local de manera regular (citas de seguimientos).
- Lo anterior se debe documentar en el SIES y se debe indicar de forma expresa el alta.

C. Alta en el Tercer Nivel

- Se alcanza estabilidad clínica sostenida y se logra el cumplimiento de objetivos terapéuticos definidos.
- Existe un criterio común en el equipo interdisciplinario tratante, de que la multiplicidad de síntomas complejos y comórbidos, han disminuido y existe un control de la situación asociada a la enfermedad que motivó el abordaje en el III Nivel. Esto no obvia que la responsabilidad del alta, es propia de cada profesional por separado.
- Se establece un plan de cierre del tratamiento, coordinación con el nivel local para su seguimiento.

- Lo anterior se debe documentar en le SIES y se debe indicar de forma expresa el alta.

Seguimiento psicológico de las personas usuarias a través de la Red de Prestación de Servicios de salud.

El seguimiento de la atención psicológica de las personas se puede brindar a través del funcionamiento de la red de interniveles que integran el modelo de atención institucional.

Con la finalidad de evitar contratiempos a las personas usuarias y maximizar el aporte de calidad y calidez que brinda el talento humano conformado por los profesionales en psicología, se establecen a continuación actividades generales de seguimiento de la atención psicológica para realizar en cada uno de los niveles de atención, pudiéndose incorporar acciones que beneficien a las personas usuarias que no se contengan en la presente oferta de servicios psicológicos siempre y cuando se ajusten a la normativa institucional vigente.

Con la finalidad de brindar pautas de acciones específicas para la prestación de servicios se procede a puntualizar sobre la oferta de prestación de servicios de psicología por tipo de establecimiento:

Áreas de salud tipo I, II y III

1. Las Áreas de Salud tipo I, deben participar de hecho, en las Comisiones Locales de Promoción de la Salud. Las Áreas de Salud tipo II o III, *solo* realizarán esta función, si su área de salud tiene a cargo EBAIS.

2. Atención de personas usuarias referidas por los EBAIS, en el caso de las áreas de salud tipo II o III, podrán recibir referencias médicas o de psicología, de los establecimientos de salud de menor complejidad de su Red. En las referencias recibidas, deben estar claramente establecidos los problemas de salud psicológicos que requieren abordaje.

3. Se emitirán contrarreferencias a los establecimientos de menor complejidad, de las personas que han sido dadas de alta, para seguimiento local, siempre y cuando no correspondan a programas especializados del establecimiento de salud del III Nivel (o que estén debidamente regionalizados en los hospitales regionales o periféricos).

4. Atención de personas usuarias referidas por Consulta Externa del establecimiento de salud.

5. Los profesionales de psicología podrán solicitar teleinterconsulta con servicios de psicología de hospitales del II nivel o del III; para ampliación de criterios, transición en la referencia o contrarreferencia de un caso y tratamiento en el nivel local.

6. La aplicación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos a las personas usuarias, se llevará a cabo según criterio del psicólogo tratante.

7. Se atenderán todos los diagnósticos de CIE-10 Capítulo F Trastornos mentales y del comportamiento (o la versión vigente), excepto situaciones ajenas al ámbito de la salud tales como:

    - diagnósticos nosológicos o descriptivos asociados a peticiones psicopedagógicas (adecuaciones curriculares o para que otros profesionales generen diagnósticos educativos),
    - peritajes de tipo judicial asociados a conducta de tipo criminológica o propia de la psicología forense,
    - peritajes psicométricos de cualquier espectro (se debe recordar que la CCSS atiende salud, por lo que la aplicación de instrumentos de medición psicológico funciona como un complemento en la evaluación clínica de las personas usuarias),
    - los problemas de aprendizaje debido a que su atención es exclusiva al Ministerio de Educación Pública.

8. Estos establecimientos, por ser parte de la puerta de ingreso al sistema de salud, deben abordar las personas usuarias que les han sido referidas para consulta externa, en función de las características y gravedad del caso, el profesional de psicología deberá decidir si es viable continuar una atención resolutiva en este contexto o solicitar una referencia, para atención de mayor especialización en el establecimiento de salud, inmediato de más complejidad.

9. Solo en caso de no existir establecimientos de salud de más complejidad en la Red de Servicios, se podrá emitir una solicitud de atención el III Nivel (hospitales nacionales), previa coordinación directa (telefónica o por medios virtuales), con el equipo de psicología de ese nivel.

10. No se deben solicitar o referir personas usuarias para aplicación de instrumentos de medición psicológicos a un nivel de mayor complejidad.

11. Toda la información producto de las atenciones a las personas usuarias, debe incluirse en tiempo real en el SIES del usuario, con los perfiles de acceso autorizados a nivel institucional para cada situación (se recuerda la obligatoriedad legal, institucional y gremial del resguardo de la confidencialidad, seguridad y privacidad de la información consignada en el SIES de la persona usuaria).

Hospitales periféricos y regionales

1. Atención de personas usuarias referidas por el I Nivel de la Red de Servicios que le corresponde, con referencia completa y claramente establecidos los problemas de salud psicológicos que requieren abordaje. En el caso de los hospitales regionales, recibirán usuarios desde los hospitales periféricos de su Red o de las áreas de salud tipo II o III (en caso de que la Red local no cuente con hospitales periféricos).

2. Se emitirán contrarreferencias al I nivel, de las personas que han sido dadas de alta, para seguimiento local, siempre y cuando no correspondan a programas especializados del establecimiento de salud del III Nivel.

3. Atención de personas usuarias referidas por Consulta Externa del establecimiento.

4. Atención de personas usuarias, referidas desde los programas especializados del establecimiento.

5. Atención de interconsultas de los servicios médicos de hospitalización y emergencias del establecimiento.

6. Atención de solicitudes de teleinterconsulta con servicios de psicología para ampliación de criterios, transición en la referencia o contrarreferencia de un caso y tratamiento en el nivel local.

7. La aplicación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos a las personas usuarias, se llevará a cabo según criterio del psicólogo tratante.

8. Se atenderán todos los diagnósticos de CIE-10 Capítulo F Trastornos mentales y del comportamiento (o la versión vigente), excepto CCSS situaciones ajenas al ámbito de la salud tales como:

- Diagnósticos nosológicos o descriptivos asociados a peticiones psicopedagógicas (adecuaciones curriculares o para que otros profesionales generen diagnósticos educativos),
- peritajes de tipo judicial asociados a conducta de tipo criminológica o propia de la psicología forense,
- peritajes psicométricos de cualquier espectro (se debe recordar que la CCSS atiende salud, por lo que la aplicación de instrumentos de medición psicológico funciona como un complemento en la evaluación clínica de las personas usuarias),
- los problemas de aprendizaje debido a que su atención es exclusiva al Ministerio de Educación Pública.

9. Toda la información producto de las atenciones a las personas usuarias, debe incluirse en tiempo real en el SIES del usuario, con los perfiles de acceso autorizados a nivel institucional para cada situación (se recuerda la obligatoriedad legal, institucional y gremial del resguardo de la confidencialidad, seguridad y privacidad de la información consignada en el SIES-EDUS de la persona usuaria).

10. No se deben solicitar, referir o contrarreferir personas usuarias para aplicación de instrumentos de medición psicológicos a un nivel de mayor complejidad.

Hospitales Nacionales

1. Atención de personas usuarias referidas por el II Nivel de la Red de Servicios que le corresponde, con referencia completa y claramente establecidos los problemas de salud psicológicos que requieren abordaje.

2. Se emitirán contrarreferencias al II o I nivel, de las personas que han sido dadas de alta, para seguimiento local, siempre y cuando no correspondan a programas especializados del establecimiento de salud del III Nivel.

3. Atención de personas usuarias referidas por Consulta Externa del establecimiento.

4. Atención de personas usuarias, referidas desde los programas especializados del establecimiento.

5. Atención de interconsultas de los servicios médicos del establecimiento.

6. Atención de solicitudes de teleinterconsulta con servicios de psicología para ampliación de criterios, transición en la referencia o contrarreferencia de un caso y tratamiento en el nivel local.

7. Aplicación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos a la PME, como complemento, según criterio del psicólogo tratante a las atenciones clínicas.

8. Se atenderán todos los diagnósticos de CIE-10 Capítulo Trastornos mentales y del comportamiento (o la versión vigente del CIE), excepto CCSS situaciones ajenas al ámbito de la salud tales como:

    - Diagnósticos nosológicos o descriptivos asociados a peticiones psicopedagógicas (adecuaciones curriculares o para que otros profesionales generen diagnósticos educativos),
    - peritajes de tipo judicial asociados a conducta de tipo criminológica o propia de la psicología forense,
    - peritajes psicométricos de cualquier espectro (se debe recordar que la CCSS atiende salud, por lo que la aplicación de instrumentos de medición psicológico funciona como un complemento en la evaluación clínica de las personas usuarias),
    - los problemas de aprendizaje debido a que su atención es exclusiva al Ministerio de Educación Pública.

9. Toda la información producto de las atenciones a las personas usuarias, debe incluirse en tiempo real en el EDUS del usuario, con los perfiles de acceso autorizados a nivel institucional para cada situación (se recuerda la obligatoriedad legal, institucional y gremial del resguardo de la confidencialidad, seguridad y privacidad de la información consignada en el SIES de la persona usuaria).

10. No se deben solicitar, referir o contrarreferir personas usuarias para aplicación de instrumentos de medición psicológicos a un nivel de mayor complejidad.

Hospitales y Centros Especializados:

Estos establecimientos deben realizar al menos las siguientes acciones.

1. Atención de personas usuarias referidas por Consulta Externa del establecimiento.

2. Atención de personas usuarias, referidas desde los programas especializados del establecimiento.

3. Atención de interconsultas de los servicios médicos del establecimiento.

4. Atención de solicitudes de teleinterconsulta con servicios de psicología de diferentes establecimientos de salud, de distintos niveles de atención, para ampliación de criterios clínico y tratamiento en el nivel local.

5. Aplicación e interpretación de instrumentos de medición psicológicos a la PME, como complemento, según criterio del psicólogo tratante a las atenciones clínicas.

6. Se atenderán todos los diagnósticos de CIE-10 Capítulo Trastornos mentales y del comportamiento (o la versión vigente del CIE), excepto CCSS situaciones ajenas al ámbito de la salud tales como:

    - Diagnósticos nosológicos o descriptivos asociados a peticiones psicopedagógicas (adecuaciones curriculares o para que otros profesionales generen diagnósticos educativos),
    - peritajes de tipo judicial asociados a conducta de tipo criminológica o propia de la psicología forense,
    - peritajes psicométricos de cualquier espectro (se debe recordar que la CCSS atiende salud, por lo que la aplicación de instrumentos de medición psicológico funciona como un complemento en la evaluación clínica de las personas usuarias),
    - los problemas de aprendizaje debido a que su atención es exclusiva al Ministerio de Educación Pública.

7. Toda la información producto de las atenciones a las personas usuarias, debe incluirse en tiempo real en el EDUS del usuario, con los perfiles de acceso autorizados a nivel institucional para cada situación (se recuerda la obligatoriedad legal, institucional y gremial del resguardo de la confidencialidad, seguridad y privacidad de la información consignada en el SIES de la persona usuaria).

8. No se deben recibir referencias de psicología del I o II nivel, si no existe el cumplimiento de protocolos de atención primaria o secundaria previa que conste en EDUS de la persona usuaria.

9. No se deben solicitar, referir o contrarreferir personas usuarias para aplicación de instrumentos de medición psicológicos a un nivel de mayor complejidad.

Poblaciones y Grupos Etarios:

Las atenciones de psicología en los escenarios avalados para la prestación de servicios abarcan a todos los grupos etarios. Es recomendable que psicología de cada establecimiento de salud, revise la configuración epidemiológica de las consultas (previa solicitud a REDES de esta información), para analizar la creación y puesta en práctica de planes de abordaje psicoterapéutico, en diferentes modalidades, por ejemplo: individual o grupal. Estos planes deben estar orientados a hacer más expedito y eficiente el abordaje de los usuarios.

El diseño de actividades, por ejemplo, para prevención primaria, del tipo psicoeducativo, deben estar orientadas a esas necesidades epidemiológicas locales, contar con un diseño metodológico, plan de acción, logística y demás necesaria para su implementación e informe, todo esto debe estar incluido dentro de los porcentajes aprobados para estas acciones y tiene que ser parte de la programación anual, debidamente aprobada por la jefatura inmediata.

Las personas usuarias deben ser atendidas con calidez y calidad, sin distinción étnica, de género, religiosa o de cualquier otra índole, que pueda configurarse en una violación a sus derechos humanos.

Organización Funcional

La Psicología de la CCSS, tiene avalada una organización funcional en los tres niveles de atención, desde el año 2014 (GM-MDD-3400-14), en la misma se especifica el sistema dentro del cual interactúan los diferentes componentes funcionales, así como las actividades que componen a la Psicología de la Institución.

La disciplina de psicología de la CCSS se incorpora dentro del modelo de complejidad ascendente. De esta forma, las Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS), abarcan a los siguientes establecimientos de salud: áreas de salud tipo I, II y III, hospitales periféricos y regionales.

Las DRIPSS tienen la potestad de gestionar y controlar los aspectos de administración y salud, que permitan coordinar y brindar atenciones en salud psicológica, acordes con el Modelo de Atención en Salud vigente en ámbitos regionales de competencia, para ello pueden organizar y poner en práctica supervisiones de los servicios a su cargo, entre ellos las correspondientes a psicología. Los establecimientos como las áreas de salud tipo I, II y III realizan

prevención primaria, atención psicológica y promoción de la salud (áreas de salud tipo I, y las áreas tipo II y III cuando tienen EBAIS a su cargo).

Por otra parte, el III Nivel está integrado por hospitales nacionales, así como por hospitales y centros especializados. Ambos son el máximo nivel de complejidad y, en el caso de psicología, se orientan obligatoriamente a las atenciones de mayor gravedad psicológica, requerimientos de programas u ofertas especializadas (avaladas oficialmente por la Gerencia Médica), la atención intrahospitalaria y hacia los servicios de emergencias.

A parte de lo anterior, en todos los niveles se realizan otras actividades como aplicación, calificación e interpretación de instrumentos de medición psicológica, sesiones clínicas y actividades de carácter logístico, así como actividades complementarias.

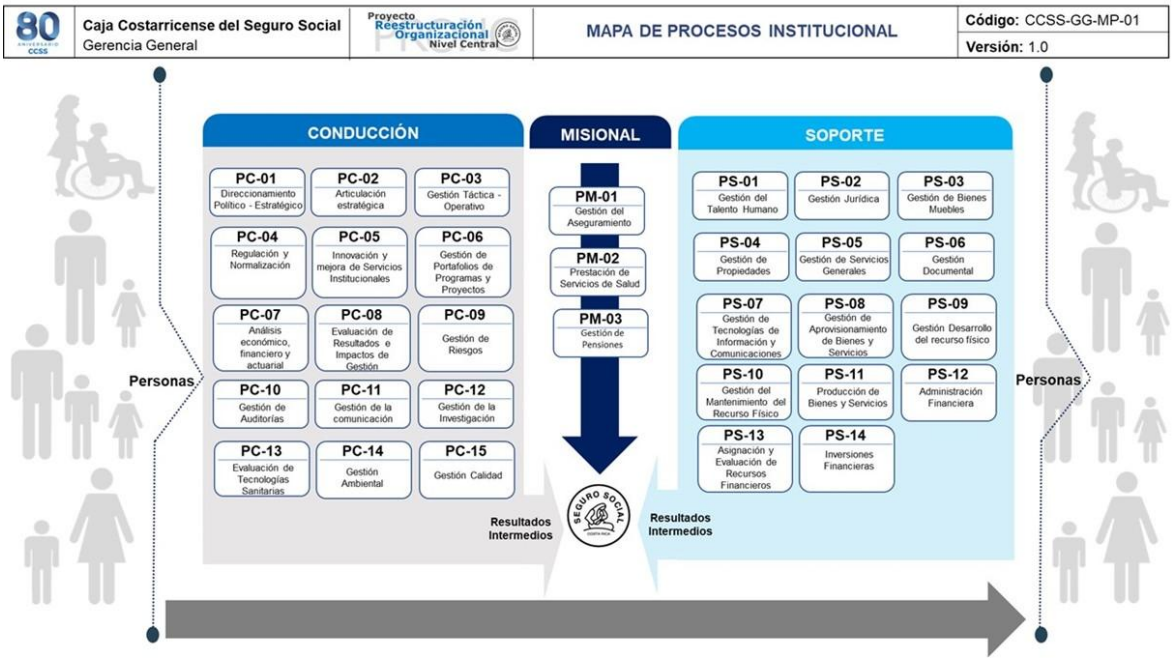
Dentro de ese orden, el documento de la “Organización Funcional de Psicología en los Tres Niveles de Atención” (GM-MDD-3400-14), expresa las políticas de funcionamiento de esta disciplina dentro de la CCSS, en la sección de la Organización Funcional se desarrollan los contenidos correspondientes. El actual capítulo, viene a actualizar lo indicado en el documento normativo homónimo y brindar aclaraciones de procedimiento (por lo tanto, de ahora y hasta una nueva actualización será el actual documento regulatorio el que rija en lo tocante a la organización funcional de psicología, dejando sin efecto el aludido GM-MDD-3400-14).

Relación con el mapa de Procesos Institucional

La actualización de esta organización funcional de psicología se inserta dentro del marco del Mapa de Procesos de la CCSS vigente (figura 7), específicamente la disciplina de psicología desarrolla sus actividades sustantivas en el proceso misional *PM-02. Prestación de servicios de salud*.

Figura 8.

Mapa de procesos institucional de la CCSS



Fuente: Mapa de Procesos Institucional, Dirección Proyecto Reestructuración Organización del Nivel Central, 2022.

Descripción de la organización funcional

La disciplina de Psicología de la CCSS se orientará a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento, la curación, la rehabilitación y la reinserción, obedeciendo al Modelo de Atención en Salud vigente, al marco institucional legal, los documentos regulatorios emanados desde la Coordinación Nacional de Psicología (debidamente avalados por la Gerencia Médica). El objetivo de las actividades de atención psicológica será: a) el mejoramiento de la salud y el bienestar psicológico de las personas usuarias y b) la continuidad de la prestación de los servicios psicológicos.

En cumplimiento de esta regulación, el personal de Psicología se guiará por los siguientes valores institucionales: dignidad, lealtad, transparencia, honestidad, respeto, excelencia, integridad, responsabilidad, compromiso y empatía.

Las políticas generales que gobierna la actuación de la disciplina de psicología en el nivel local son las siguientes:

- Los ejes de salud de psicología se organizan en función de: la promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria (de acuerdo con el tipo de establecimiento de salud en cada Nivel de Atención), con un enfoque poblacional, orientado a una atención centrada en la persona usuaria, sensible al género y sin discriminación a las poblaciones.

- Se aplicarán a las personas usuarias las técnicas basadas en evidencia, avaladas en las prestaciones de servicios de salud de psicología, que estén debidamente consideradas en los documentos de regulación técnicos, que se orienten a los principios bioéticos de beneficencia, mínima maleficencia, autodeterminación del usuario y justicia en salud.

- La atención psicológica que se ofrezca en consulta externa y en otras atenciones, debe desarrollarse con base en los procedimientos y técnicas terapéuticas establecidas, basadas en la evidencia y en las buenas prácticas internacionales en la materia (tal como establece la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley General de Salud).

- Los profesionales en psicología deberán utilizar el expediente de salud o el SIES de las personas usuarias, los formularios y los cuadros estadísticos aprobados por el Área de Estadísticas de Salud y anotarán los diagnósticos nosológicos según CIE-10 (o versiones posteriores), todo ello en atención a la normativa de la CCSS que rige este conjunto de requisitos de trabajo y que son de uso obligatorio.

- Solo se agendarán personas usuarias, por los canales oficiales de la CCSS (SIAC) y en los tipos de consulta aprobados para psicología, las personas usuarias deben atendidas con referencias y las interconsultas son el medio para acudir a hospitalización o urgencias/emergencias. **No se deben tener expedientes de los usuarios no oficiales y toda la información de estas personas, debe estar consignada en el SIES**.

- Se atenderán a todas las personas referidas a los servicios de psicología, ya que es un derecho a la salud. Será el criterio del profesional de psicología el que establezca el tipo de evaluación, tratamiento o aplicación de procedimientos que correspondan al caso abordado.

Funcionamiento Interniveles:

Cuando el profesional tratante documente, que producto de la aplicación de los documentos de regulación técnica vigentes, ha implementado un plan de atención psicológica, el cual no ha logrado la evolución y progresión esperada en las

personas tratadas acorde con los objetivos terapéuticos y que la persona usuaria ha mostrado síntomas de agravamiento, que no pueden ser tratados por las especialidades existentes en el nivel en que se aborda el caso y que requiere de atención especializada, por parte de profesionales de un establecimiento de salud de mayor complejidad, debe proceder con la realización de la referencia de la persona usuaria y darle de alta en el nivel que está emitiendo la referencia. Lo cual se debe consignar en el SIES, de manera que se garantice el trabajo en red según la complejidad diagnosticada y requerida.

- Para los casos, en que las condiciones psicológicas mejoren y progresen hacia la estabilidad y recuperación psicológica en respuesta a la terapéutica utilizada, el profesional tratante procederá a dar de alta y cerrar el caso, cuando sea requerido el seguimiento ambulatorio, podrá referirse a la persona usuaria a niveles de menor complejidad.

- El proceso de atención psicológica finaliza en el momento de cumplir con los objetivos psicoterapéuticos o en el momento en que se confirme y se documente, por parte del profesional tratante, que la condición psicológica de la persona usuaria es estable psicológicamente y que no le representa mayores dificultades en el manejo de su situación y en especial en el funcionamiento cotidiano, se procederá, entonces, a dar de alta y consignarlo en el SIES.

Funciones por nivel de atención

Áreas de Salud tipo I, II y III

Psicología en este modelo orientará su actividad de trabajo, principalmente, a la promoción de la salud (exclusivo de las áreas de salud tipo I, y de las II y III cuando tengan EBAIS a su cargo) y a la prevención primaria (con enfoque poblacional) y les brindarán seguimiento a las actividades de prevención secundaria, sobre todo en las áreas de salud tipo II y III.

Los procedimientos de promoción de la salud, prevención primaria y secundaria de la enfermedad utilizados por Psicología, se deberán basar en técnicas científicas basadas en la evidencia, pues son las que garantizan beneficios comprobados a la salud de las personas.

Especialmente en este nivel de atención se realiza la prestación de los servicios básicos de salud que comprenden acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, curación y rehabilitación de menor complejidad, que se practiquen en los ámbitos, de consulta externa o ambulatoria general.

Las acciones se orientarán a las personas y a su comportamiento en cuanto a la salud y al ambiente en el cual viven, permanecen, trabajan o se recrean.

Adicionalmente la persona usuaria puede ingresar a psicología mediante referencia médica institucional, excepto que la institución cuente con un convenio interinstitucional autorizado por las autoridades correspondientes, no obstante, en la actualidad no existe un convenio interinstitucional con referencia directa a psicología, por ello, en todos los casos derivados de los EBAIS o de Áreas de Salud, Emergencias, Urgencias, deben ingresarse mediante referencia emitida por medicina, y cuando sea el caso a través de la red de prestación de servicios de psicología.

El profesional en medicina o psicología realizará las referencias que, de acuerdo con su criterio técnico considere pertinente a los profesionales en psicología del primer nivel, quienes, según su criterio técnico, definirán el curso del tratamiento de la persona usuaria.

Es importante destacar que existe una Guía Institucional de consulta externa, (si existe una actualización se deben seguir esas versiones), que establece como deben ser recibidas y remitidas las referencias dentro de los establecimientos de salud, además de aplicar el Lineamiento para referencias y contrarreferencias a psicología vigente.

Para las acciones de prevención, los profesionales en psicología procederán según el perfil epidemiológico del establecimiento de salud del primer nivel a gestionar las actividades requeridas por la población adscrita, para ello, incorporará estas actividades sean de tipo grupal o individual en el Plan de gestión técnico de psicología acorde con el presente Manual.

Los profesionales en psicología del primer nivel de atención podrán realizar toda actividad relacionada con la aplicación de instrumentos de medición psicológica que sean requeridos por las personas usuarias, siempre y cuando no retrase el proceso de atención psicoterapéutica.

En el cuadro 13, se pueden observar las actividades básicas de las Áreas de Salud tipo I, II y III

Cuadro 13.

Actividades de Psicología de la CCSS en las Áreas de Salud tipo I, II y III.

Subproceso	Procedimiento	Actividades sustantivas	Actividades complementarias
Atención Integral de la Salud Psicológica	Promoción de la Salud Psicológica (exclusivo de las Áreas de Salud tipo I, las tipo II y III lo asumirán cuando tengan EBAIS a su cargo)	• Proyectos de promoción de la salud psicológica y stilos de vida saludables.	• Actividades técnico logísticas.
	Atención psicológica	• Consulta externa. • Aplicación de procedimientos. • Prevención primaria • Sesiones clínica técnicas (uni o multidisciplinarias).	
Comisiones y equipos con aval de Gerencia Médica para participación de psicología.			

Fuente: Elaboración propia

Hospitales Regionales y Periféricos

Las actividades de Psicología en estos ámbitos se enfocarán al trabajo en prevención secundaria y terciaria (principalmente). Basarán sus intervenciones en la epidemiología de la región y atenderán a las personas usuarias, de acuerdo con procedimientos de atención psicológica, basados en la evidencia y en las buenas prácticas internacionales.

En el cuadro 14 se observa un cambio en las actividades sustantivas, ya que, al caracterizarse el establecimiento de salud como uno de tipo hospitalario, las consultas y atenciones implican un nivel de experticia y especialización de tipo clínico; esto supone la habilitación para valorar, atender y tratar a personas usuarias con una serie de diagnósticos que requieren un mayor nivel de complejidad y capacidad instalada.

Cuadro 14.

Actividades de Psicología de la CCSS en el II Nivel de Atención (con hospitalización).

Subproceso	Procedimiento	Actividades sustantivas	Actividades complementarias y de apoyo
Atención Integral de la Salud Psicológica	Atención psicológica	• Consulta externa. • Atención intrahospitalaria. • Atención en Servicio de Emergencias. • Procedimientos de evaluación psicológica. • Sesiones clínicas técnicas (uni o multidisciplinarias).	• Actividades técnico-logísticas.
• **Comisiones con aval de Gerencia Médica para participación de psicología.**			

Fuente: Elaboración propia

Hospitales nacionales, hospitales y centros especializados

Corresponde a la prestación de servicios de atención curativa y de rehabilitación de la más alta especialización y complejidad. El área de influencia del nivel terciario trasciende la del secundario y abarca el territorio de varias provincias, cantones y distritos.

Cuadro 15.

Actividades de Psicología de la CCSS en los hospitales nacionales, hospitales y centros especializados

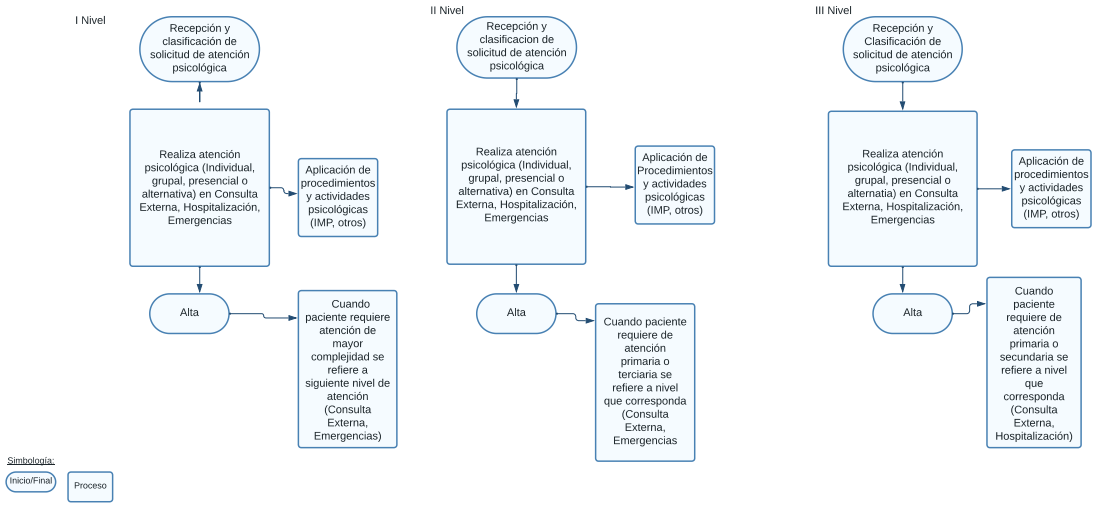
Subproceso	Procedimiento	Actividades sustantivas	Actividades complementarias y de apoyo
Atención Integral de la Salud Psicológica	Atención psicológica	• Consulta externa. • Atención intrahospitalaria. • Atención en Servicio de Emergencias. • Procedimientos de evaluación psicológica. • Sesiones clínicas técnicas (uni o multidisciplinarias).	• Actividades técnico-logísticas. Comisiones con aval de Gerencia Médica para participación de psicología.
• **Comisiones con aval de Gerencia Médica para participación de psicología.**			

Fuente: Elaboración propia

A modo de corolario a esta sección, se expone en la figura 9 las rutas que puede seguir una persona usuaria, para ser atendida en la consulta externa de psicología, en los tres niveles de atención.

Figura 9.

Fluxograma de las rutas para la atención psicológica de las personas en los tres niveles de atención de la CCSS.



Fuente: Elaboración propia

Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud

- Los contenidos y procedimientos incluidos en este documento y todos aquellos emitidos para la prestación de servicios de psicología, deben ser supervisadas en su ámbito regional por las DRIPSS.

- Psicología en I y II nivel serán supervisados por las Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud, de acuerdo con los contenidos avalados en el Instrumento de Supervisión Integrado de Psicología (ISIP, en su versión vigente y actualizaciones posteriores).

- El objeto de las supervisiones realizadas por las DRIPSS, mediante el uso del ISIP serán la mejora en la gestión de los procesos de los servicios de psicología, con el fin de fortalecer las prestaciones de servicios de psicología a las personas usuarias que requieren de estas atenciones.

Coordinación Nacional de Psicología

- La Coordinación Nacional de Psicología es el órgano técnico institucional, con mayor rango en la Institución para el tema de regulación y normalización en materia psicológica, se orienta a la regulación técnica de la disciplina, emitirá

todos los criterios técnicos requeridos para la gestión correcta de los servicios de psicología y será el ente que definirá las actuaciones de la disciplina, en los procesos de prestación de servicios en esta materia.

- La Coordinación Nacional de Psicología es la encargada de regular y sistematizar el accionar de la disciplina de Psicología en la Institución; las regulaciones que eleve esta instancia a la Gerencia Médica y que sean avaladas por esta última, serán de acatamiento obligatorio para los servicios psicológicos de la Institución.

- La Coordinación Nacional de Psicología diseña, desarrolla e implementa la normativa técnica, guías e instrumentos (y todos aquellos productos regulatorios que acuerpe la CCSS), que se requieren para la prestación del paquete psicológico en los establecimientos de salud, con el propósito de garantizar su aplicabilidad e implementación.

- El III Nivel de Atención será supervisado con la utilización de instrumentos y herramientas diseñados para tal fin, a efecto de garantizar el cumplimiento de la normativa institucional, la competencia técnica y el mejoramiento continuo de la calidad, y dicha acción será implementada por la Coordinación Nacional de Psicología.

Equipamiento e infraestructura

Equipamiento

Los establecimientos de salud que cuenten con profesionales de psicología, en atención directa a las personas usuarias, deben mantener al menos el siguiente equipamiento en los consultorios y espacios físicos asignados a Psicología de la CCSS.

1. Computadora actualizada con software de ofimática, conectividad a Internet y recursos de hardware para que puedan ser instalados los programas de evaluación psicológica y cualquier otro que sea requerido para los procesos de evaluación.

2. Acceso a sistemas de tecnología informática para conexiones inalámbricas (MIFI, tabletas, entre otros), avalados institucionalmente.

3. Instrumentos de medición psicológicos para las consultas y atenciones clínicas. Dichos instrumentos serán los contenidos en el Catálogo Institucional de Bienes

y Servicios, no se podrán incluir instrumentos diferentes al Catálogo, sin previa consulta a la Coordinación Nacional de Psicología.

4. Mobiliario para consulta (sillas, sillones, mesa de trabajo, escritorio, papelería, entre otros).

5. Mueble con llave o seguridad, dentro del consultorio asignado a psicología, que permita el resguardo de los manuales, cuadernos y hojas de respuesta de los instrumentos de medición psicológicos. Este material solo puede ser custodiado por psicología y ninguna otra disciplina de salud o administrativa, puede asumir el cuidado de estos. Sin embargo, las compras de dichos instrumentos, sí debe realizarse de acuerdo con lo normado institucionalmente para tal efecto.

6. Otros relevantes a este rubro y que pueden variar de acuerdo con el nivel de atención, la zona, las poblaciones y la región.

Infraestructura

De acuerdo con el Decreto Nº 30571-S (Ministerio de Salud, 2002) dónde se publica el Reglamento de Habilitación de Establecimientos de Salud y Afines, se indica que entre los establecimientos dedicados a la atención en salud, se encuentran todos aquellos relacionados con trastornos psicológicos y de la conducta (en el decreto recibe el código B219), a su vez la Ley General de Salud (Asamblea Legislativa, 1973) en su artículo 69 sienta las bases para considerar a estos (establecimientos) como sanitarios.

Con el fin de generar líneas básicas acerca de este tipo de establecimiento, se retoman las indicaciones emitidas por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, en el año 2009:

1. Contar con una adecuada ventilación e iluminación, preferiblemente natural.

2. Estar pintado con colores claros que reflejen la luz y brinden un ámbito cálido y amable para los usuarios.

3. Garantizar la privacidad del paciente, tanto visual como auditiva, hacia y desde otros locales o circulaciones.

4. Tener el mobiliario mínimo necesario para brindar una adecuada atención, tales como: sillas cómodas, escritorio, archivo para el resguardo instrumentos psicológicos y documentos importantes, un armario con seguridad para el almacenamiento instrumentos de medición psicológicos, un mueble donde

colocar material de psicología para la atención de personas menores de edad y de los usuarios en general.

5. Cumplir con la legislación nacional en lo referente a seguridad, prevención y minimización de riesgos de accidentes y desastres, tales como incendios, temblores, entre otros.

6. Cumplir con la ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades) en lo referente a la infraestructura para que pueda ser accesible y transitado por todo tipo de personas usuarias, sin encontrar el paso o ingreso restringido por barreras arquitectónicas.

7. Cumplir con los lineamientos municipales respecto a los permisos de funcionamiento, así como cumplir con el “Reglamento General de Habilitación de Establecimientos de Salud y Afines”.

Evaluación de resultados

Se utilizarán los indicadores de resultados, gestión y proceso que mantenga vigentes y actualizados el Área de Estadísticas en Salud (AES), para la consulta externa, interconsultas y emergencias; así como los establecidos por NOVAPLAN para psicología.

Declaración de Intereses

Los autores de este documento declaran que no ha existido ningún tipo de conflicto de interés en su realización. Que no poseen relación directa con fines comerciales con la industria sanitaria en dicho tema, no han recibido dinero procedente de la investigación o promoción de dicho tema. Además, declaran no haber recibido ninguna directriz de parte del solicitante o pagador (CCSS) para variar técnicamente los resultados presentados en este documento. Cada colaborador llenó su respectivo formulario de declaración de intereses, el cual fue analizado por el ETCM y tomó las debidas acciones; los formularios serán custodiados por cinco años.

Contacto para consultas

Coordinación Nacional de Psicología. Correo electrónico: cnsp_ars@ccss.sa.cr

Anexo 1

Referencias

Asamblea Legislativa. (1943). *Ley N.º 17: Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). https://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/708/ley-constitutiva-ccss.pdf

Asamblea Legislativa. (1973). *Ley N.º 5395: Ley General de Salud.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Asamblea Legislativa. (1978). *Ley N.º 6227: Ley General de la Administración Pública.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Asamblea Legislativa. (1998). *Ley N.º 7739: Código de la Niñez y la Adolescencia.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Asamblea Legislativa. (2002). *Ley N.º 8220: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.* Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyproteccionciudadano.pdf

Asamblea Legislativa. (2002). *Ley N.º 8292: Ley General de Control Interno.* Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leygeneraldecontrolinterno.pdf

Asamblea Legislativa. (2002, septiembre 4). *Ley General de Control Interno (Ley N.º 8292).* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Asamblea Legislativa. (2012). *Ley N.º 9063: Ley de atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de violencia.* INAMU. https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/ley_n._9063.pdf

Asamblea Legislativa. (2013). *Ley N.º 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (modificada).* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). https://piam.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/Ley%207935.pdf

Asamblea Legislativa. (2018). *Ley N.º 6144: Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (reformada).* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Asamblea Legislativa. (2022). *Ley N.º 10245: Ley de Cuidados Paliativos.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=97049

Asamblea Legislativa. (2023). *Ley N.º 10412: Ley Nacional de Salud Mental.* Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).

Biblioteca Digital de Seguridad Social [BIDISS]. (2025, marzo 25). *Función sustantiva o básica.* Glosario de términos en Seguridad Social. https://biblioteca.ciess.org/glosario/content/funci%C3%B3n-sustantiva-o-b%C3%A1sica

Byron Cisneros, E. E., Chávez Rivera, M. E., Herrera Cabrera, D. F., Torres Fernández, J. P., Gallo Mendoza, J. G., & Armijos Robles, L. A. (2017). *How to measure management effectiveness in health institutions?* Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 36(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002017000300017

Cacace, P. J., & Giménez-Lascano, G. (2022). *Modelos de atención centrados en la persona: evolución de conceptos humanizadores de nuestras prácticas.* Revista Mexicana de Medicina Familiar, 9(2), 63–72. https://doi.org/10.24875/rmf.21000070

Caja Costarricense de Seguro Social. (1998). Hacia un nuevo modelo de Atención Integral de la Salud. Gerencia de Modernización.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2002). *Manual de organización de las áreas de salud.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2003). *Módulo 3: La atención integral.* CENDEISSS. https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/La%20gestión%20en%20la%20atención%20integral%20en%20salud

Caja Costarricense de Seguro Social & Universidad de Costa Rica. (2003). *Fundamentos conceptuales y operativos del Sistema Nacional de Salud y del Modelo de Atención de la Salud.* Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2004). *La conceptualización de la salud en el Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud.* https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/La%20conceptualización%20de%20la%20salud

Caja Costarricense de Seguro Social. (2012). *Catálogo de definiciones de actividades de atención en los servicios de salud.* AES-NORETEC-2-2-2011-001.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2012). *Normas para la conformación de comisiones en la CCSS.* GA-DDO-001.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2014). *Instructivo: Sistema Estadístico Integrado de Psicología.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2014). *Manual de adscripción y beneficio familiar.* https://www.ccss.sa.cr/normativa

Caja Costarricense de Seguro Social. (2014). *Manual de procedimientos de la consulta externa en psicología.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2015). *Reglamento del Sistema Mixto de Atención en Salud.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2016). *Evaluación sobre la implementación de la clasificación de las áreas de salud.*
https://aissfa.ccss.sa.cr/arc/auditoria/informes/ASS-125-2016.pdf

Caja Costarricense de Seguro Social. (2017). *Manual de procedimientos: Alta programada.* https://repositorio.binasss.sa.cr/bitstreams/0f031ad2-6aea-49db-95c3-1aa520517555

Caja Costarricense de Seguro Social. (2017). *Informe técnico para el fortalecimiento de la atención de emergencias en la CCSS.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2018). *Manual Gestión de los Servicios de Consulta Externa.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2019). *Marco Conceptual y Estratégico para el Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2019, marzo). *Manual operativo del Reglamento EDUS.* GM-AES-MO-002.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2020). *Definición, conformación y funcionamiento del Gobierno de las Redes Integradas*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2020). *Lineamiento para la definición y creación de tipos de consulta en psicología.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2022). *Instructivo adscripción e identificación de la persona usuaria.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2022). *Lineamiento técnico de modalidades no presenciales.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2022). *Informe de clasificación de áreas de salud.* https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/

Caja Costarricense de Seguro Social. (2023). *CCSS 2041: Una mirada al futuro.* https://aissfa.ccss.sa.cr/flip/

Caja Costarricense de Seguro Social. (2023). *Plan estratégico institucional 2023–2033.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2023). *Servicios de Salud de la CCSS.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Lineamiento para la atención telepresencial.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Lineamiento para registro de interconsultas en EDUS.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Lineamiento para Promoción de la Salud en menores.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Lineamiento para referencias y contrarreferencias en Psicología.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Plan de Promoción de la Salud 2023–2027.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2024). *Recordatorio REDES sobre altas clínicas.*

Caja Costarricense de Seguro Social. (2025, marzo 10). *Símbolos Institucionales.* https://www.ccss.sa.cr/cultura-organizacional

Carballo-Quesada, L. (2022). *Accesibilidad a los servicios de salud…* https://doi.org/10.51481/amc.v64i2.1284

Caron, R. M., Noel, K., Reed, R. N., Sibel, J., & Smith, H. J. (2023). *Health promotion* https://doi.org/10.1016/j.focus.2023.100167

Clèries Costa, X., Sarrado Soldevila, J. J., & López Vicente, P. (2007). *La atención primaria*

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. (2024). *Guía de buenas prácticas para la telepsicología.*

Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica. (2024). *Perfil general del profesional en psicología.*

Colegio Oficial de Psicólogos. (2024, agosto 14). *Psicología Clínica y de la Salud.*
Criado, M., & Barchiertto, A. M. (2005). *Importancia del enfoque interdisciplinario*
CIEMaps. (2025, junio 27). *Clasificación de Procedimientos (v4.1.00).*

Dalgleish, T., Black, M., Johnston, D., & Bevan, A. (2020). *Transdiagnostic approaches to mental health problems…* https://doi.org/10.1037/ccp0000482
Departamento de Planeación Nacional. (2024). *Prestación del servicio.*

Etchemendy, E., Rasal, P., & Fernández-Álvarez, J. (2024). *Abordajes transdiagnósticos*

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2017). *Perspectiva de género.*

Godoy, D., Eberhard, A., Abarca, F., Acuña, B., & Muñoz, R. (2020). *Psicoeducación en salud mental*

Groth-Marnat, G. (2009). *Handbook of psychological assessment.*

Hernández, R. (2021). *Bases metodológicas para la gestión por procesos*

Hunsley, J., & Mash, E. J. (2007). *Evidence-based assessment.*

Instituto Nacional de Estadística [INE]. (2025, marzo 10). *Factor de riesgo.*

Julio, V., Vacarezza, M., Álvarez, C., & Sosa, A. (2011). *Niveles de atención*

López, M., Gillet, S., & Zabaletta, V. (2022). *Aportes al constructo bienestar psicológico*

López Puig, P., García Milian, A. J., Segredo Pérez, A. M., Alonso Carbonell, L., & Santana Felipe, A. (2014). *Procedimiento para medir la capacidad resolutiva*

Meyer, G. J., Finn, S. E., Eyde, L. D., Kay, G. G., Moreland, K. L., Dies, R. R., … & Reed, G. M. (2001). *Psychological testing and psychological assessment*

Mirapeix, C. (2017). *La integración más allá del diagnóstico*

Nebot, M., López, J. M., Ariza, C., Villalbí, J. R., & García-Altés, A. (2011). *Evaluación de la efectividad*

Normas que regulan las relaciones laborales entre la CCSS y profesionales en salud. (2004, julio 2).

Organización Mundial de la Salud. (2016). *Marco sobre servicios de salud integrados*

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2011). *Redes Integradas de Servicios*

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2021). *Establecimientos de salud resilientes*

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2025, junio 25). *Un enfoque intercultural y participativo*

Real Academia Española. (2025, febrero 17). *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.).

Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española. (s.f.). *Diccionario panhispánico de dudas.*

Victoria García-Viniegras, C. R., & González Benítez, I. (2000). *La categoría bienestar psicológico*

World Health Organization [WHO]. (2023). *Primary health care.*

World Health Organization [WHO]. (2024). *Tracking universal health coverage*

World Health Organization [WHO]. (2024). *Hospitals.*

World Health Organization [WHO]. (2025, marzo 10). *Determinants of health.*

World Health Organization [WHO]. (2025). *Emergency and critical care.*